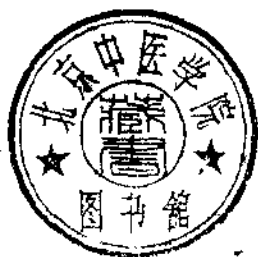


C/1012
100

簡要針灸正骨

馬繼興 薩仁山 編

74158/501



一九五四年·北京

36057



中醫進修講義
簡要針灸正骨

書號1553 32開 48頁 67千字

編者	馬繼興	薩仁山
出版	人民衛生出版社	
	北京南長街3號	
發行	新華書店	
印刷	人民衛生出版社長春印刷廠	

(東北版)
定價3,800元

1954年9月第1版
1—10,000

簡要針灸學

馬繼興編

新序

前 言

這是一本在中醫進修學校裡的試用針灸學教材大綱，而這一門課程的總的要求，就是如何能够使參加進修的同學們在較短時期中，初步掌握了針灸療法的基本知識，並運用到實際中去。

我們應當在學習過程中特別注意學員的實習問題，要指導學員力求作到嚴密的消毒步驟與無痛方法。並且要在課堂的組員交互實習基礎上，進一步地為病人服務。

針灸療法是祖國古代經驗醫學中的一門物理療法。其中包括了不少的豐富而具有治療價值的內容，同時也具有着某些錯誤的形而上學的唯心主義思想。因此我們應當打破一切神秘色彩的陳腐學說，特別是應當反對那種「可以意會，不能言傳」的陳腔濫調。建立起科學的實事求是的學習態度，而批判地接收祖國的這種寶貴遺產。

我們不能指出，學習「新針灸學」和學習「舊針灸學」是基本不同的。在這一個問題上，朱璉同志早就指出了二者的區別是在於前者必須要初步掌握了現代科學的基礎醫學知識，而後者沒有。因此在進修針灸學的過程中，為了避免在針灸手術時所產生的各種偏差，故必須具備了科學的基礎醫學知識，特別是生理解剖學。

對於這本簡要講義初稿中所存在的缺點與錯誤，我個人懇切地希望讀者同志予以幫助與批評，以期於更好地得到改正。

馬 繼 興 1952. 10. 11.

目 錄

第一章 針灸療法概論……………(1)

第一節 針灸治療的生理學作用機構……………(1)

1. 刺激物對於神經系統的影響
2. 間接刺激反應對於人體作用的重要意義
3. 神經系統對於人體的調理作用和針灸治療上的關係
4. 針灸刺激部位及其對於內臟疾病的影響
5. 存在於針灸療法中的問題和進一步闡明的道路

第二節 針灸治療法的應用範圍與禁忌：……………(9)

1. 針灸療法的應用範圍
2. 針灸療法的禁忌

第二章 正規刺針手術的操作……………(15)

第一節 刺針前的準備……………(15)

1. 工具的準備與應用
2. 消毒法
3. 刺激的基本手技

第二節 刺針手術的實施……………(23)

1. 在打針柄時應注意
2. 刺針的方向與深度
3. 應用刺針手技的目的
4. 常用刺針手技的方法
5. 古代常用的補瀉手法及其批判
6. 刺針時的局部感覺
7. 人體對於針灸刺激反應之特點

第三節 拔針法及刺針後處理……………(35)

1. 拔針法	
2. 拔針困難的原因與處理	
3. 拔針後的一般處理	
第三章 在刺針中對於所發生的異常現象的處理	(38)
1. 暈針現象	
2. 折針	
3. 穴內曲針	
第四章 灸法和其他古代理療法	(41)
1. 灸法表現	
2. 放血療法	
3. 溫針及火針	
4. 拔罐針	
第五章 測定人體刺激點的方法	(45)
第一節 取穴法的基礎	(45)
1. 體表取穴的標識	
2. 取穴法的類別	
第二節 取穴的方法	(47)
1. 古代取穴法的測量單位標準	
2. 根據比例數值的測定標準	
3. 「折寸法」的應用法	
第三節 選擇刺激點位置的原則	(51)
1. 古代經絡經穴概念的批判	
2. 關於決定針灸刺激點位置的標準問題	
3. 刺激點的選擇與阿是穴的應用	
附錄：(針灸參考資料)	(62)
常用要穴——(一)頭頸部 (二)軀幹部 (三)上肢部	
(四)下肢部	

第一章 針灸療法概論

第一節 針灸療法的生理學作用機構

針灸療法是我國古來民間應用之一種物理療法，實際上可分為刺針法與灸療法二種，前者為利用金屬製之細針刺入身體一定位置之皮下深部，藉這種器械的刺激，以達到治療之效果；而後者則在一定位置之皮膚表面藉燃點乾燥艾葉用溫熱刺激，以達治療之效果者。

這兩種療法雖然在治療方法上不同，但是根據古來經驗，在應用這兩種療法時，都要選擇人的表面的上的一些有一定位置的「點」作為刺激的目標，古人就將這種點叫做「穴道」或「經穴」；就是我們所稱的「刺激點」。關於全身共有多少穴道的說法，其說不一，例如根據素問氣府論所記為 365 穴（實際數目僅 313 穴），甲乙經共 351 穴，千金方共 349 穴，銅人腧穴針灸經共 354 穴……等說。但每一個穴道都有不同的治療效力與不同的作用。

按照古人的揣想，連接於各穴道之間的有若干線路，全身最主要者有十四條，故叫做十四經脈。但是十四經脈的說法只是一種假想的說法，我們無論在屍體或活體的解剖上都是找不到證據。

但是為什麼針灸療法作用於人體的一定刺激點後，就會對於內臟的異常病變發生某種程度上的影響，從而得到治療

疾病的效果呢？

要想回答這個問題，根據我們現在既有的知識限度和僅有的實驗材料都還不能作出一個完整的客觀理論上的回答。但是從我們所已知的科學知識中，特別是在偉大的蘇聯學者巴甫洛夫思想的指導下，我們可以初步的認識到針灸療法所引起的生理機轉乃是和巴甫洛夫氏的神經論學說——現代醫學的最基本的原理——一致的，因此我們應當先從神經論談起。

一、刺激物對於神經系統的影響——一個生活的人體不論是在正常或有病狀態，都經常要接受一些內部的或外來的刺激。這些刺激物的種類相當繁多，例如在正常生理上的呼吸空氣，分泌液體和食物等，都是一種刺激物；在病理上的病原體，病理部位的變化以及各種治療的藥物等也都是刺激物。我們用針灸治療，就是利用器械刺激的針體或溫熱刺激的艾葉這種刺激物來治療的。

但是不論是什麼刺激物，作用於人體後，在一定的程度上就會引起人體的反應，這種反應形式一般說來不外二種。

→ 其一就是「直接反應」。也就是受刺激的局部組織與於刺激物的直接接觸結果所引起的反應，這種反應是不通過神經系的。

另一種就是由於刺激物對於皮下所分佈的感覺神經末梢發生接觸後，藉着神經反射的作用而表現的效果，這就是「間接反應」或稱之為「反射性的反應」。

直接反應是一種原始的反應形式，它的反應方法僅限於作用的局部，例如刺激某一肌肉所引起同一肌肉的收縮等。

間接反應是一種高級的反應形式，是精神經系統的成長

而出現的。這種反應方法往往不僅是可以表現在受刺激的局部，而最重要的乃是它可以由於神經系的傳導作用而表現在刺激的遠隔部分。

因此我們也就可以知道針灸療法所呈現的器械或溫熱刺激，一方面可以有作用於皮膚或皮下局部組織的效果（即直接反應）；同時也可以藉着這些皮膚刺激點下面所分佈的神經末梢將刺激傳達到中樞神經系去，而由於神經系的反射作用，再藉着遠心神經的徑路對於一定的內臟或組織引起機能上的影響。

關於這一個現象的解釋，我們不妨引證巴甫洛夫的說明，就會更易於理解。巴甫洛夫說道：「僅刺激求心神經末梢，由於反射作用就可以影響到遠心神經所支配的臟器與系統。」而在針灸的治療實際上正是對於一定的皮下求心神經末梢的刺激，而予以各內臟及系統疾患的一種間接反應的有效治療方法。

二、間接刺激反應對於人體作用的重要意義——根據上述，我們就會發生一個新的問題，那就是：

人體對於刺激反應的形式既然有上述兩種，那麼到底是那一種起最重要的決定性作用呢？

神經論指示我們，由神經系統所引起的反射性影響的「間接反應」在高等動物（特別是人類）的適應外界的刺激上，是特殊重要而有決定性意義的。至於在受作用局部的「直接反應」却是非常次要，並且是沒有決定意義的。

爲什麼刺激神經系統所引起的間接反應會有如此重要的生物學意義呢？首先我們應當從神經系統對於人體正常與病態時的總的指導作用來看。

根據巴甫洛夫學說，神經系統隨着動物的進化過程在人體內已發展到相當完備與複雜的條件，並且它已成為人體各器官與系統的總指導者，因而在人類適應外界環境與內部環境時的絕大多數的刺激傳導方法（即反應刺激的方法），都要經過神經系統才能够順利完成。

在這一點上，是具有神經系統的高級動物（包括人類）和低級動物基本上不同之處（因為低級動物沒有神經系統，它們對於刺激反應的方法，都應用着直接反應的方法，不可能有間接反應）。也可以說，由於神經系統在動物進化史上的出現後，間接的反應（即通過神經系統的反射動作來完成的反應）才逐漸而且是穩固的代替了直接的反應（即不經過神經系統的反應）。動物愈是進化（如人類），這種間接反應亦愈發達與重要，而直接的反應則逐漸消弱。不過這並不是不承認直接反應在人體作用上的一定地位的意義，但是這種直接的反應往往要在一定的程度上受到間接反應（亦即神經反射）的控制，並且可以在一定程度上受到間接反應的削弱或取消。關於這一點，很多蘇聯學者都曾提供了一些實驗材料的證明，我們在這裡不多引述。

三、神經系統對於人體的管理作用和針灸治療上的關係——正是由於神經系統在人體內所完成的「間接反應」的重要規律，所以不僅在正常的人體活動中，神經系統起了重要作用，而且在疾病的過程中也主要是由於神經系統的障礙而產生的。神經系統擔任了幾乎所有疾病的原因，在這一點上我們必須提出了關於神經系統的營養作用學說，這就是巴甫洛夫學說所指出的神經性營養。所謂神經性營養，就是由於動物進化到更高級的階段後，隨着神經系統功能的逐漸集中結

果，根據了個體的需要，神經系統就能夠決定各個組織的化學物質的改變和性質；也就是說神經系統對於各組織器官的管理方式不單純是在作用上的支配，而且也可以在一定程度上改變了它們的形態的構造與性質的成分。必須說明在這一個新的醫學觀念上乃是和過去的將狹窄的「機能性病」與「器質性病」的舊的區分觀念上是有着截然不同的。在那個舊的觀念中，僅狹義的把少數沒有形態變化的疾病歸之為機能性病，而對於有着顯明病理變化的疾病，一直被認為神經系統在這方面所起的作用是不大的。

巴甫洛夫學派的無數豐富事實材料，反駁了那個舊的論據，而明顯的指出無論任何疾病，其最初作用於人體（或其他有機體）的局部感覺神經末梢，要首先接觸到這個病理的刺激而由此傳達到中樞神經系，然後反射的對各部分組織發出刺激反應。

巴甫洛夫寫道：「在機體內外部的各種刺激因子（注：包括生理刺激及病理刺激）攻擊着不同的神經感受器，此種攻擊變成神經過程即興奮現象；興奮沿着神經纖維傳導路到了中樞神經系統，按照中樞神經系統固定聯系的支持。興奮又沿着另外的導路到工作器官，而變成該器官細胞的特殊過程，可見各種（刺激）因素與機體的各種活動有着規律性的聯系，就如同因和果的關係。」

根據了上述的基本理論出發，可知我們不僅在生理上對於正常人體生活現象的解釋上是離不開這種神經論的；我們在病理上對於疾病的原因，病理變化過程和病理的轉歸上也是離不開這種神經論的，而最後我們在治療以及預防的方法與理論上，還是離不開神經論的。神經論明確的告訴我們，神

經系在人體內的重要作用。神經論也告訴我們一個重要的科學事實和今後進一步研究的可能性，那就是在治療上我們可以利用刺激神經末梢的間接反應，改善內部器官的機能上甚或是形態上的某些條件。

而具體利用了這種方法，並且獲得了經驗上的多數實際效果的一種祖國醫學遺產就是針灸療法。

因此，朱璉同志在新針灸學中所指出的：「針灸療法不是直接以外因為對手，因而也不着重對患部組織直接的治療，而是激發與調整神經機能以達到治病的目的」的說法是很正確的。

四、針灸刺激部位及其對於內臟疾病的影響：

皮膚和內臟之間是存在有相當的神經聯系，構成這種聯系所引起的反射現象就叫做「內臟皮膚反射」及「皮膚內臟反射」。內臟皮膚反射是一種防禦性反應。這種反應在正常人體情況下，是見不到的。而當某些內臟受到傷害時，則往往在一定的皮膚區域產生該局部皮膚的感覺過敏現象。如癢楚疼痛等。這種皮膚過敏感覺的特徵，往往是限局於一定區域，可以發現其感覺的最高點；同時在一定部位的皮膚過敏區均多與一定的內臟有關（譬如在心臟病時於左側鎖骨下部有皮膚過敏區；在脾臟病時於肩胛部皮膚發生過敏區等）。關於這種皮膚與內臟的相聯性，很久以來就曾引起了許多學者的注意，並首先應用這個現象的結果到診斷學方面，作為藉着一定區域皮膚的過敏現象來判斷某些內臟疾病的標幟。

蘇聯的臨床學家潘欽柯氏等，在巴甫洛夫學說的基礎上，結合了這個臨床現象，更進一步地應用於治療方面去。在這方面，潘氏主要是根據了巴甫洛夫氏的負誘導現象的原理，成

功地獲得了下列的推論。

潘氏認為在內臟有病時，第一，在與該內臟有關的皮膚過敏區予以局部麻醉，就可以使與其相當的大腦半球中已陷於興奮狀態的皮膚分析器和該內臟轉入於抑制狀態。這是因為麻醉的效果，不僅可以通過皮膚內臟反射的方式減低興奮的程度，並且可以改變興奮狀態成為保護性之抑制狀態。第二，與上述方法同時，在與上述皮膚過敏區域相鄰近的正常皮膚區域，予以額外性的刺激物時，（如以紫外線照射，芥子泥等刺激物），那麼必然在大腦皮質內引起一個新的神經興奮中心區域（即興奮灶）。而這個新的興奮灶是距離原來的皮膚過敏部的疾病所引起的興奮灶在位置上是相接近的，也就是說有兩個相互接近的興奮灶。如果新興奮灶的興奮程度強大而持久時，就可以產生負誘導現象，就是說可以使有病的興奮灶消除，而以新的興奮灶代之。因此，潘氏認為利用新的無關刺激的結果，可以完成有效的治療作用。而這一現象乃是蘇聯的另一學者烏赫透姆斯基氏的優勢規律學說相符合的。

潘氏的上述推論，業已在其臨床治療中得到了充分滿意的證明。

針灸療法在通過皮膚以影響內臟的神經生理學機理，在很多方面，均是和上述現象相一致的，在針灸治療中，在很多場合刺激部位的選擇主要是以皮膚過敏區為主的。這就是古代所稱之為阿是穴（或天應穴）。刺激這些部位的主要目的，是利用抑制作用的方式藉以減輕皮膚分析器乃至其相當內臟的興奮現象。使疾病發展過程減輕以促使其就愈。此外，我們也利用針灸的刺激作用於過敏皮膚的鄰近區域，而這些鄰近區域是正常皮膚表面無任何過敏現象的，我們刺激這些無

關區域的結果，往往可以引起疼痛(或緊張)的轉移作用，以使疾病的治癒。而後一種刺激方式，是與上面所說的由於大腦皮膚分析器中新的興奮灶之產生，引起皮質內的負誘導現象，因而使大腦皮質內的舊興奮灶減弱與消除，使皮質內的作用恢復正常化的結果所致。

當然，內臟與皮膚的神經聯系機構之進一步的研究及其有關的許多問題，目前還是未能充分解決的。然而這些現象的啓示，對於針灸學的發展道路，是有着非常重要的意義的。

五、存在於針灸療法中的問題和進一步闡明的道路——根據上面我們所說的針灸療效原理的基本觀念，在巴甫洛夫學說的光輝指導下，已能使我們有了一步更明顯的認識。但是僅靠這些原則性的論證去解釋許多個別的針灸刺激點的療效原理，還是遠不夠的。一直到目前為止在針灸學領域中的新的認識還是極其膚淺的。我們到現在還不能夠客觀地、有根據地解釋下列事實，即：

最基本的問題是各別針灸刺激點的效果是否對於各器官與系統的作用有某種程度與性質上的不同？這些不同對於治療上的影響是什麼？

因為有許多近代學者是主張不用個別刺激點的。這些學者主張刺激身體上任何局部都會同樣有效。

同時我們也有鑒於自古以來，無論在文獻上或實際上各針灸醫師所用的同一名稱的穴道位置也有極大的出入。因此我們認為對於各別「穴道」是否有確實可靠的作用，這些作用是什麼，怎樣才能更好的表現這些作用出來，就應當是最值得我們研究的基本問題了。

其次我們對於刺針技術上的不同刺激形式所引起的效果

也未能給予以正確的解釋。同時我們應當進一步研究爲什麼同一個刺激點用同樣的方法，對於同一臟器的兩種相反的疾病都完全能獲得效果的問題，例如下痢與便秘都是腸的疾病，在藥物治療中，前者要用止瀉藥，而後者要用瀉藥，但是針灸療法則可以在同一刺激上發生不同的治效。

談到在針灸療法的本身治效上，是否包含着一定程度上的精神療法的暗示作用問題，恐怕也要成爲今後研究的一個課題。

至於由針灸刺激的局部所引起之定型的神經反射徑路是否存在的問題，也是屬於一個原則性而待解決的。而欲求這一些問題的解決，是和偉大的巴甫洛夫學說的基本原理所不能分割的。因此我們必須更好的加強對於辯證唯物主義的巴甫洛夫學說的學習，以進一步研究和闡明針灸療法的科學面貌。

第二節 針灸療法的應用範圍與禁忌

一、針灸療法的應用範圍：

針灸療法在臨床上應用範圍很廣泛，但是也不是所有的病都可以應用本法，其適應症的範圍，現在還沒有相當的科學統計資料。但根據新針灸學及一般臨床家比較有確實效果者略舉如下以資參考。

1. 消化系病——口內炎、急慢性咽炎、扁桃腺炎、耳下腺炎、食道炎、急慢性胃炎、急慢性腸炎、牙痛、胃痛、胃擴張、消化不良、胃腸潰瘍、痔瘡、便秘。

2. 呼吸系病——氣管及支氣管炎、喘息、肺炎、百日咳。

遺尿症、膀胱炎、腎盂炎、膀胱癌、膀胱麻痺、
各種神經痛、神經麻痺與癱瘓、神經衰弱、精神病。

3. 泌尿系病——腎炎、腎盂炎、膀胱炎、遺尿症、膀胱癱瘓、膀胱麻痺。

4. 循環系病——神經性心悸亢進、狹心症、不整脈、血壓亢進。

5. 神經系病——腦貧血、腦充血及腦溢血（對症療法）各種神經痛、神經麻痺與癱瘓、神經衰弱、精神病。

6. 肌肉與關節病——肌肉風濕、急慢性關節風濕、類風濕性關節炎。

7. 婦產科症——妊娠惡阻、月經困難、月經閉止、月經過多、陰道炎。

8. 小兒科病——小兒急痢、小兒消化不良。

9. 眼耳鼻喉科病——急慢性喉頭炎、喉頭肌麻痺、結膜充血、結膜炎、中耳炎、衄血、鼻炎。

10. 傳染性疾病——瘧疾、黑熱病、回歸熱、感冒。

11. 內分泌病——甲狀腺腫、糖尿病。

上面所舉者僅是主要的適應症範圍，其中所包括的一些病尚屬於對症療法範圍。

二、針灸療法的禁忌：

在針灸療法之禁忌方面可以分三方面談。

1. 不適於應用針灸的生理條件，主要者如下：

（一）解剖方面者——對於重要內臟與大血管附近的穴道不宜於作深度之刺激，以免刺中內臟，例如胸部的心、肺，頸部的氣管和頸動靜脈，腹部之肝、胃、腸、膀胱、腎……等。有很多針灸醫生往往應用長針直透腹膜下方的胃、腸，這種刺法特別是在消毒不完全時是有危險的。而根據多數學者的實驗，用淺刺法的效力並不遜於深刺。故我們的意見是對於內

臟表面的刺激點最好不要應用這種帶有危險性的深刺。

(二) 患者之某種生理狀態——加在刺針前的過份疲勞，或興奮太過，或在飽食之後等，此外對於過於虛弱之患者，尤其要特別慎重考慮，避免馬上用針或不予用針。

2. 針灸之禁忌症——一般地說，只要消毒充分，避免在重要內臟的深刺，和考慮到患者的上述條件後，針灸的禁忌範圍是很小的。但是我們也不能不考慮到針的效果問題，故我們同意新針灸學的說法：

「一般的病，由於調整內部機能，都能幫助治癒，問題是針的發生作用不大（註：「不大」二字是我們附加的）。還受手法限制，如果有特效藥可治，又怕就誤治療時機的就應該算是禁忌症……如果沒有特效藥，針灸確能用對症療法收些功效的即使是傳染病（如霍亂、流行性腮腺炎、麻疹）也可以用來治療。」

3. 古來相傳之禁針灸穴的學說與批判——古代對於禁針穴與禁穴的說法是很多的，但是這些說法的意見並不統一，並且有很多相反的意見，因此不論古人有所謂「二十二禁針穴」「二十七禁針穴」……等的說法。但是實際上這些「禁穴」的說法已在後世許多針灸醫生們的臨床應用中否認了很多。現在我們把這些所謂禁針穴的不同說法列表如下：

穴名	主張禁針的著作或學者	主張不禁針的著作或學者
雲門	入門	其他各家（但多數禁深刺）
巨骨	素註	其他各家
承泣	大成、銅人、入門、三才圖會	甲乙、說約、明堂
四白	三才圖會、入門	其他各家

人迎	銅人、和語抄、東醫、會元	甲乙、素註
缺盆	入門	其他各家(但多數禁深刺)
乳中	千金、甲乙、東醫入門高等	銅人聚英
天樞	千金	其他各家
氣衝	銅人、素註	其他各家
伏兔	東醫	其他各家
衝陽	素註	其他各家
箕門	銅人、和語抄、入門聚英、針灸大成集	甲乙、說約
腹結	入門	其他各家
青靈	大成、會元、坂本、高等、等書	說約、備要
天容	和語抄、大成、聚英	甲乙、說約
顴髎	入門	其他各家
肩貞	松元：「一說禁針」	其他各家
臂臑	入門	其他各家
承光	入門	其他各家
絡却	三才圖會、坂本、圖翼等	素註、聚英、會元、大成、說約、備要等
玉枕	三才圖會、坂本、圖翼等	同上
心俞	入門、三才圖會	其他各家
腎俞	備要：「一雲：禁針」	其他各家
白環俞	入門	其他各家
膏肓	扁鵲神應針灸、會元	其他各家
承筋	銅人、甲、乙、入門、千金、坂本	說約備要
橫骨	銅人、坂本、高等、入門、大成等	甲乙、備要、素註
然谷	東醫	其他各家

會宗	銅人、明堂、會元、大成	高等、甲乙
三陽絡	銅人、甲乙等	說約 <i>石板醫經 百人</i>
天關	入門	其他各家
角孫	入門	其他各家
蠡息	松元	其他各家
腕子邪	入門	其他各家
上關	銅人	其他各家(但多數禁止深刺)
承靈	大成、會元	其他各家
淵腋	入門	其他各家
中瀆	入門	其他各家
陽關	入門	其他各家
地五會	入門、甲乙	其他各家
急脈	富永、玉森	松元
會陰	銅人、聚英皆微禁針。大成、會元等均禁針	甲乙、入門、說約
神眼	甲乙、素註	其他各家
水分	銅人	甲乙、素註
鳩尾	甲乙、千金、入門	其他各家(但多數禁深刺)
體中	諸書皆禁刺	千金
脊中	三才圖會、入門	其他各家
神道	同上	其他各家
臍戶	銅人、素註、三才圖會	明堂、入門、說約
百會	富永	其他各家
神庭	諸書皆多禁針	會元:「不宜深刺不過二分」
靈台	諸書皆多禁針	松元
中樞	松元:「一說禁針」	金鑑、圖翼

由上表中我們可以看到在文獻上的「禁針穴」並沒有絕對的意義。此外，我們根據這些穴道的解剖特點和臨床證明，也可以進一步的看出所謂禁針乃是和刺針的深度解剖的部位和患病的情況等有密切關係，而很難從一個局部的「點」來決定。至於禁灸在一般的皮膚面上，除了避免灸瘡形成的部分（如顏面部）外，對於這種局部的小火傷來說其禁忌的價值，恐怕也是很小的。

第二章 正規刺針手術的操作

第一節 刺針前的準備

一、工具的準備與應用

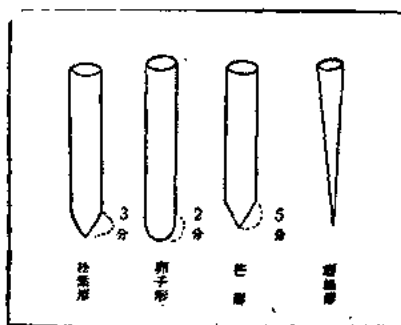
1. 毫針——毫針皆多以金、合金、馬啣鐵或鋒鋼絲為原料製成。其形狀可分為三部敘述：

(一) 針柄部——又名龍頭，為持針的部分。其形狀甚多，但在實用觀點上，必須與針體相結合，不易脫落者為最好。在應用管針時之針柄尤應選擇不宜過粗之針柄，並針柄表面光滑一致者。

(二) 針體部（即針身部）——針柄均以均勻粗度之金屬細絲製成，唯有粗細長短區別：在粗度方面大致可分為三種，即針體之直徑在 0.4—0.3 毫米者為「粗針」，直徑在 0.3—0.2 毫米者為「中等針」，直徑在 0.2—0.1 毫米者為「細針」。一般應用上均為中等粗度之針。但不論任何粗度，針體均必須保持光滑均勻，否則即不可應用。在針之長度方面，應根據刺針時之深度決定針體之長短。一般在應用上，短針（1.0—2.5 厘米）多應用於四肢末梢端之淺刺，而中等長度之針（2.5—4.0 厘米）多應用於四肢及胸背、頭面等處之刺激，至於長針（4.0 厘米以上），則僅用於皮下水平刺或斜刺。

(三) 針尖部——根據針尖之形狀有下列四種：

磨細形——根據針尖的特徵是由針腳部漸次向下細呈



銳角之磨細。這種針尖最爲銳利，且利於刺入皮膚，但往往引起皮膚之不快感及針之彎曲爲其缺點。

芒形——本針尖之形狀，爲在針尖之前端上方五分處仍與針體作同一粗度，但在其下方則磨成急度的銳角。這種針尖不易屈曲。

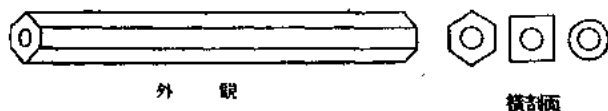
卵形——針尖如鷄卵之銳端，而針體之粗度則毫無變化，這種針尖不易彎曲，並易於刺入，但略有鈍痛感。

松葉形——爲卵形針尖與芒形針尖之中間形，有圓滑之針尖。這種針尖沒有上述的缺點，所以在應用上是一種最好的針尖形式。

2. 鋒針——鋒針又名三稜針，多爲鐵製或鉛製，爲應用於瀉血時的工具。形狀一般較毫針爲粗，針體呈圓形或三稜形，較細之鋒針多用於刺激四肢末梢部微細血管，而較粗之鋒針則用於刺破四肢淺在之大靜脈血管。

3. 針管——針管爲應用毫針刺入身體時之一種輔佐工具，首先應用針管者爲日人杉山和一氏。最初之形式係以細竹之內腔作爲針管，及後則改爲金屬製成，形狀多爲細長之管

狀，內爲一圓筒，其外則呈八角、六角、四角或圓形不等。



4. 針的保藏及整理——爲了避免金屬針體的生鏽，在保藏中應塗有防腐之油脂劑中，普遍應用凡士林與脫脂棉之混合物，置於一定之針容器中作爲插針用途。在保藏中應隨時注意針體表面之光澤與平滑。如發現有腐蝕、生鏽或針體彎曲，針尖缺損時，即應在用前加以整理。在去鏽工作上可以細砂土或砂布反覆打磨針體或用磨石磨出針尖，而對於針體之彎曲者則宜斟酌情況，應用器械使之直針，或另行處置。因爲我們對於針的選擇是應當特別慎重的，如果勉強用了不適宜的針，在手術效果上就會不能避免的造成一些偏差的。

二、消毒法：

消毒法在刺針手術中是非常重要的。有些人存着：「針灸自古以來就沒有消毒手續，也一樣看好病」之漠視消毒意義的觀念，是非常錯誤的。在我們所遇到許多的例子中因不消毒的結果而造成的刺針業務過失與病人貽後症的事實，是屢見不鮮的。有很多的針灸醫師由於用沒有消毒的針，刺入了腹部，而使病人發生了慢性腹膜炎、腹膜癒合的例子很多；也有很多針灸醫師透過了病人的肥厚不潔的衣服（有時隔着棉衣或皮衣）把針刺入病人身體，因而在這種情況下就引起了很多皮下發炎甚至化膿的情況。我們知道病原微生物的體積是非常渺小的。而即是在針體外表上最光滑的表面上，如果用高倍放大觀察時，仍有極多粗糙與凹陷的地方。如

果我們沒有完備的消毒手續，細菌就乘隙潛入體內而形成另外的危害性疾病。因此我們在刺針手術前，就必須要嚴格地執行消毒手續。在刺針前的消毒手續簡括可分為以下兩項：

1. 手術者和手術野的消毒——手術者本身首先應注意者為手指之清潔及消毒，應剪短手指爪甲，並清除污垢。在手術前應用溫水及肥皂洗滌，並用指刷用力刷洗乾淨。必要時應以棉花蘸 75% 之酒精摩擦手指 2—3 分鐘。

在患者施針局部之手術的處置，較完善之方法為先用 5—10% 之碘酒塗拭於手術野，塗拭方法為先自刺激點的中心開始，漸次環繞周圍。面積不要涉及過大，待乾燥後更用 75% 之酒精如上法清拭，這種消毒方法比較最安全。但在刺針慣例上為了簡化起見，也可僅用 75% 之酒精清拭，在已經消毒完畢之手術野，不得沾污任何未經消毒之物體，否則即當重行消毒。

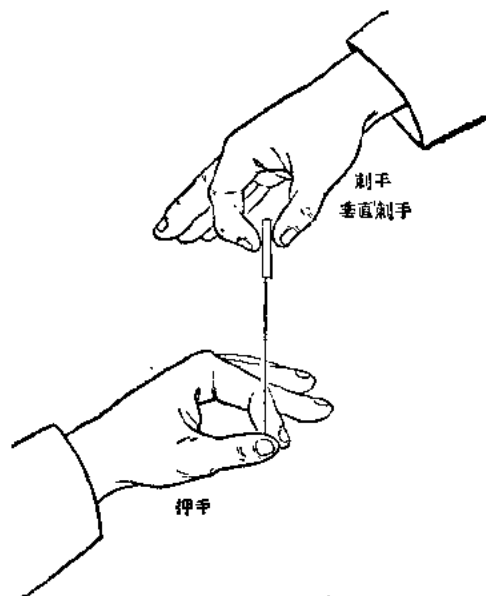
2. 針的消毒——關於針的消毒，我們現在一般所用者均為 75% 之酒精，即在每次用針前 5 分鐘將全部毫針（包括針柄）皆浸入於酒精液中，用時取出。

三、刺針的基本手技：

刺針的基本手技就是持針和固定刺激點局部位置的方法，習慣上我們把持針的手叫做「刺手」，而將固定刺激點局部的手叫做「押手」。在刺針技術上兩手的姿式是很重要的，故在下面介紹一些常用的方法：

1. 刺手——刺手普通最常用者為醫者之右手。但亦有因習慣上應用左手者，刺手中最重要之部分為拇指與食指，用以把持針柄之用，其持針方法雖有種種方式，但可簡單分為三種：

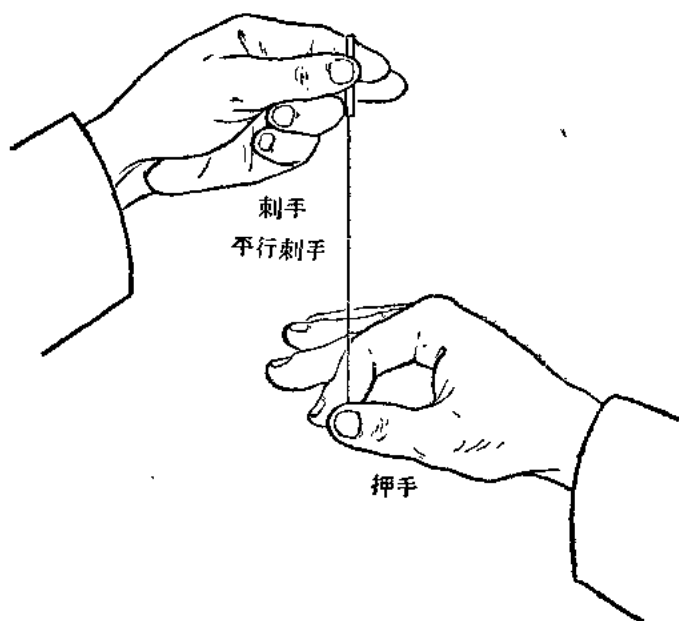
(一) 垂直刺手——這種刺手方式應用於刺針法之進針時。即以刺手之拇食二指指尖向下垂狀之把持針柄，而將其餘三指張開，本刺手之優點為便於撚針法之刺入與拔出。



(二) 平行刺手——這種刺手最常應用，其方法即以拇指球與食指球相對，而以二指與皮膚面呈平行之方向刺入及拔出者（參考圖）。

(三) 斜插刺手——這種刺手多應用於長針及斜刺時，其方法即以刺手之拇食指（嚴格消毒），把持針體之中間而以針體之上端與針柄斜依於食指第一節內側而漸次推動針體，使之下降，以達刺針目的之方法。

2. 押手——押手普通均以左手為之，其主要用途有下列幾點：



(一) 押手可以在一定之程度上壓迫皮膚表面，故可以防止或減少刺入時之疼痛。

(二) 押手可以固定針體或針管，而不使其搖動與脫逸。

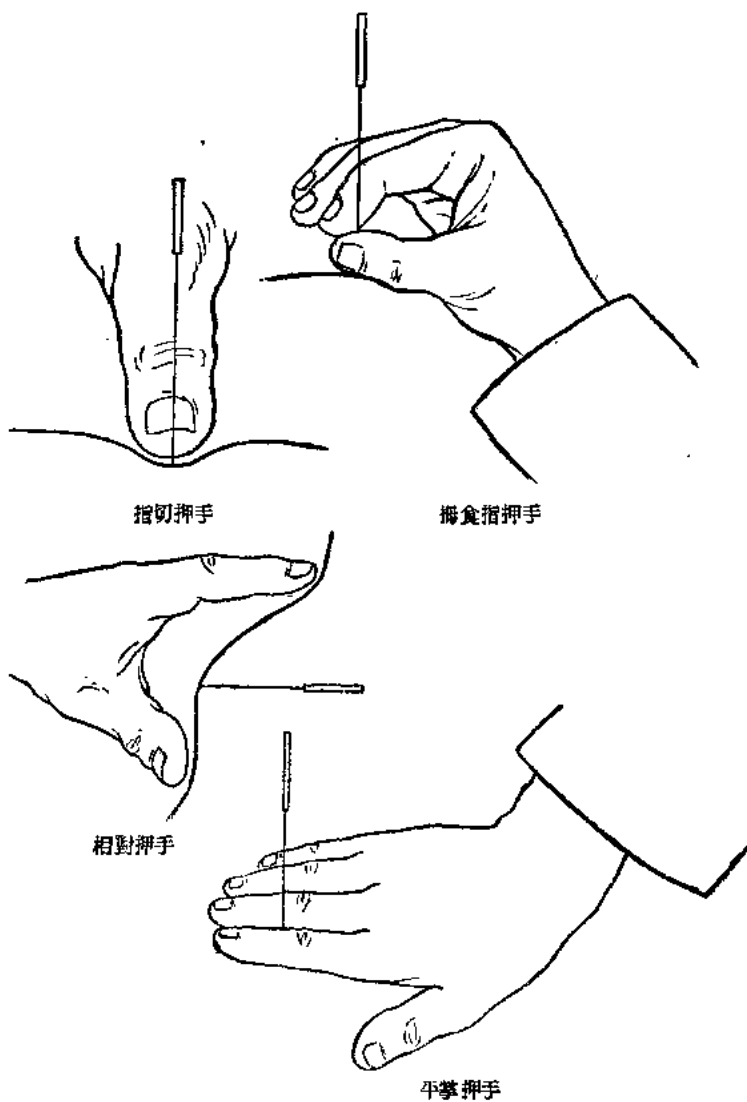
(三) 使進針有一定之方向。

(四) 防止患體有動搖而致曲針與折針之危險。

(五) 較不利用押手者刺入皮膚較易。

押手之方法自古以來根據流派之不同，種類極多，但最常用者不外四種：

第一種：指切押手——此即為我國沿用已久的「重切法」即以押手之拇指爪（貯留其中等長度，但須嚴格消毒之後才可



應用，最好易於假爪甲以便於摘取消毒）用力按壓所欲刺針之刺激點部位的邊緣。壓按之程度也應根據患者之感覺略有伸縮，一般而論，用力壓按時往往可以在刺針前預使皮下之感覺神經受到刺激，而當刺針時有防痛的作用。惟應用本法時，在入針時必須緊貼爪甲之邊緣，否則，難免有稍許之痛覺發生。

第二種：拇食指押手——以押手之拇指球與食指球的尖端相合併，作成輪狀，其他三指（中指、無名指、小指）則張開而押壓皮膚表面，以防動搖。在拇食指之間則緊挾住針管或針體，並稍用力向皮膚下方壓迫之姿式，這種方法用者很多，並且也很方便。

第三種：相對押手——本種押手多用於胸部及背部皮膚面較廣闊並施行平水刺者，其方法即開張押手之拇指與食指，使二指呈平行狀之在皮膚表面向反對側推移皮膚使呈現人為之皺裂，而用針在相反之方向水平之刺入皮膚者。這種方法在皮膚易於移動之位置時可以防止疼痛之發生，並可避免深刺入內部以損傷臟器，也是常用的一個押手。

第四種：平掌押手——這種押手為將押手五指緊閉，平掌放置於皮膚上方，然後在指間（食指與中指之間，中指與無名指之間）之第一、二指關節部緊閉挾針，勿令動搖，而刺入之方法。本種方法多用於腹部及腰部之刺針，或並列之刺入二、三針時。

除上述外，又可以利用針管來代替押手，針管的應用法後面再述，此外尚有不利用押手方法單用刺手者，但是在進針的時間上往往要浪費很多時間，並且沒有上述押手的幾個優點。僅是在消毒方法上比較更為嚴密而已，

第二節 刺針手術的實施

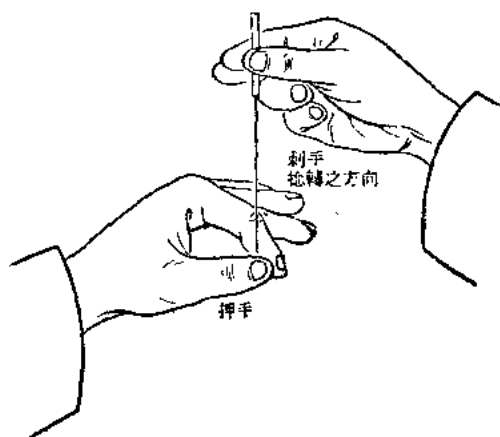
一、直刺法——這是我國針灸醫師常用的一種方法，即在押手的協助下，將針直接穿通皮膚達於皮下之方法。這種方法應用的需要較粗的毫針方能刺入，過細的毫針則因易於屈曲，是不太適宜的。並且直刺法的插針是無需捻轉，所以入針時可以很迅速的達到所欲穿刺的目的，拔針時也很迅速，因此應用這種方法時的押手是特別重要的。一般要用較重的押手，以防患者動搖，並可以防止痛苦。如果押手的力量很輕微，那就不可避免的會使患體有痛感了。

在這裡必須要補充說明的是，我們人體表面感覺神經特別是痛覺末梢纖維的分佈，在接近表皮部分也越密集，越往皮下深部，痛覺神經纖維漸形稀少，所以在刺針時的痛覺感覺主要還是在皮膚的上部。我們刺針手術之主要要求之一就是防止疼痛，要達到這一個目的，可用較重的押手，因為這樣可以使皮下之感覺神經纖維預先受到一定程度上的刺激，故在運用適當時就可防止痛覺之發生，對於刺針手術上就有着其特殊的意義了。

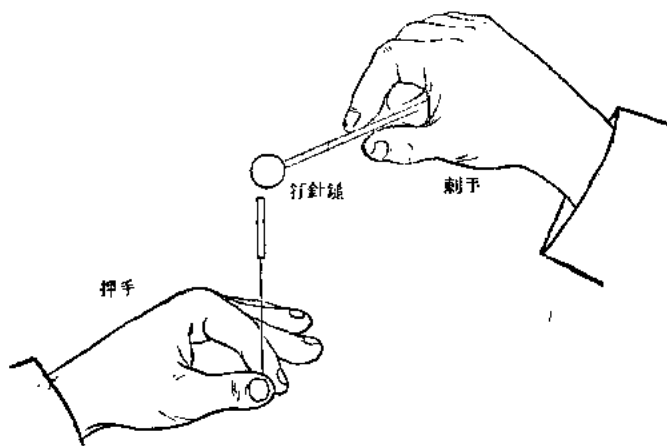
二、撚針法——撚針法為以醫者刺手之指頭在持針柄時用旋撚之方法進行刺針者。撚針法一般也要有押手輔佐，其捻轉之方式有二：一即為單側捻轉，這種捻轉是將針柄始終向左方或右方之同一方向捻轉者，不過這種捻轉法很不容易操作，特別在針體不直，刺針傾斜及受到皮下周圍組織之壓迫時，就很難運用自如。一即為左右捻轉，這是將針柄既向左又向右之方向迴轉刺入者，這種方法比較容易和實用。

不論在那一種捻轉時，刺手都必須作隨着捻轉而加以一定的壓力，漸次刺入皮下，拔針時亦同。這其中押手的有無是很有關係的，在沒有押手的場合，雖然也可刺入，但是需時較長。在時間上比較浪費，並且沒有押手的安全。所以我們還是要在嚴密指頭消毒的情況下，應用押手為宜。

三、打針法——打針又名擊針。為1573—1614年間，日人御園意齋氏所創始，為應用一種特製之打針槌幫助毫針使其易於刺入皮膚之方法。打針槌之形狀為一細棒，其前端是有圓形或圓柱形之木槌。關於打針，現在已很少應用。惟根據日本之古典記載，則為以左手之中指與食指間保持針體而以針



尖接觸皮膚面上，以右手持打針槌輕輕叩擊針柄上端，俟刺入二、三分後即行中止，不要使針尖入於皮膚內三分以上。這種方法，叫做「穿皮」。在穿皮之後，入針方式就不再以打針槌，而是以指頭捻轉入內了。



所以打針法只是利用於穿皮階段時之一種方法，是可以避免在穿皮時的痛楚的。

四、管針法——管針法為日本延寶・貞享年間杉山和一氏所創始，為現在最多用之方法。這種方法主要是在穿皮時應用針管來代替押手。每一個針管之長度均較之同組之毫針稍長3分，這樣就可以在將針放入針管內，並將針管置於皮膚上時，可微出針柄三分。

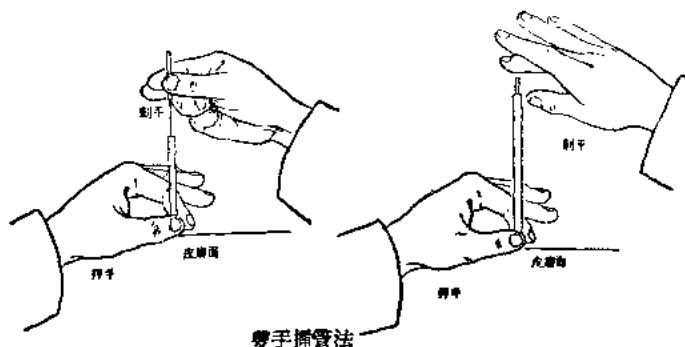
在實用上管針法之一般操作如下：

以醫者之押手持針管，刺手持針柄，將針管下口放置於刺激點之皮膚面上，並將毫針從針管之上部插入。此時再行用中指叩打針柄，使針柄上端沒入於針管上口內為止。然後把針管取下，用燃針法將針刺入皮下。

1. 在叩打針柄時應注意——中指指頭要作平起平落之垂直方向叩打，要輕快迅速，並且最好叩打一次即可穿皮，否則最多叩打二、三次後就必要完成穿皮手術，因為叩打次數太

多，會引起病人的不愉快的感覺。

2. 刺針的方向與深度——刺針的方向應根據刺激點的



局部位置而決定之，但總的來說，不外二種：

一種是「直刺」。這就是將針體與刺激點之皮膚面呈垂直之方向刺針，直刺一般不適於過深，特別是在內臟附近施針時。

一種是「斜刺」。斜刺時，針體與刺激皮膚面所呈之角度是要根據解剖位置之特點來決定的。如果針刺之角度很大，入皮後的方向大致與皮膚水平之方向在皮下深入者，一般就叫做水平刺（或是皮下刺）。這種水平刺因為僅在皮膚下方，往往可以用較長的針，刺入很長。這樣一方面可以避免意外的危險，另一方面也可以得到較大的刺激面，故在臨床上多應用之。

不論是直刺或斜刺，如果在刺針中遇到入針困難的情況時，就要及時處置，或中途改變刺針的方向或拔出針體。

3. 應用刺針手技的目的——針灸既為調整神經系統以影響並改變異常之活動機能，故在針灸治療的目的上，就是準

備解決要以怎樣的條件才可以使處於異常興奮狀態的身體組織達到「抑制」，或使處於異常抑制狀態的身體組織恢復其「興奮」。在前者就是古人稱之為「實者瀉之」的瀉法；在後者就是相當於「虛者補之」的補法。

在針灸刺激的手技上，怎樣才能達到「補法」及「瀉法」（或興奮與抑制）的目的呢？在這一方面是與決定身體組織反應的一些基本因素有關，而這些因素是有着廣泛的生物學意義的，簡單地說有下列二種。

第一種基本因素，是和患者本身當時的生理狀態有密切關係。而這種生理狀態是受體內外的種種複雜因素所影響的。蘇聯的偉大生理學者維金斯基把這種生理狀態叫做「機能活動性」。

第二種基本因素，就是要決定於針灸刺激方式方面的一些因素。我們知道，當着患者在一定的生理狀態下（也即在恒定不變的機能活動性狀態下），患體對於外來刺激的反應效果要決定於下面的四類因素：

（一）「強度」因子——針灸刺激反應的效果，必須與刺激的強度因子有關。這是很多學者的實驗所證實的。

在輕度微弱刺激時，能引起輕度的興奮作用，但是隨着刺激力量的不斷增強，興奮程度也伴隨着增高，並達到一定程度。在興奮達到一定程度時，刺激如再加強，則所得之效果必呈現負性的抑制狀態。因此可以說抑制作用之出現，並不等於刺激作用之被消失，而實際上却為另一方面作用的加強。

這種強弱的刺激，在刺針手技方面，主要為表現於：(1)刺激時所用力量之大小，(2)刺激局部的面積，(3)刺針的深度及方向，(4)針體直徑之粗度等方面者。

(二) [時間] 因子——針灸刺激反應的效果是與刺激的時間有關的。這一問題，也是在很多科學實驗中得到證明的，即在同一強度之刺激中，短時間的刺激能引起興奮現象，但刺激時間的延長（長時的刺激），也可以由刺激力量增強而轉變為抑制作用。這種時間長短的刺激，在刺針手技中，一般多表現於針灸醫師所常用之 [置針術]（或 [留針術]）中。

(三) [頻率] 因子——所謂頻率，就是指在同一時間內，刺激作用的次數。假如刺激的力量相等，刺激的頻率小（即在同一時間內刺激的次數少）時，一般可表現興奮效果。隨着頻率的增加，反應的效果也要增強，最後也可轉為抑制狀態。

在刺針手技中，刺激的頻率，往往是以下面所說的雀啄法和間歇法等方式來表現的。

(四) [距離] 因子——除上述三個因子外，針灸刺激反應的效果，與刺激的距離因子有關。所謂距離乃是指刺激部位與病灶區域（或皮膚過敏區域）間的遠近。因為在針灸治療上之某些場合中（特別是前面所說的無關刺激之誘導現象時），刺激部位對於病灶距離的遠近，同時也可以決定了在皮膚分析器中所引起的擴散作用強度問題。因為在較遠距離的刺激部位上，其擴散作用的強度，一般是低於較近距離的。

總上所說，我們可知，刺激所引起的反應效果的表現，是和上列諸因素有着極密切的關係的。我們針灸工作者，必須掌握了這些刺激與反應的總的規律，並加以具體地應用，這也就是現代的科學 [補] [瀉] 觀念。

在臨床上我們每每可以看到這兩種作用所適應之某些症

狀的效果，例如在運動性神經機能減退時所表現之神經麻痺，或感覺性神經機能減退時所表現之知覺脫失等，均需要用興奮之刺激；而在運動性神經機能亢進時所表現之神經痙攣與感覺性神經機能亢進時所表現之神經痛等，則均需要用抑制之刺激。

此外我們也可利用這兩種相反的作用方法，在神經系統的影響下，對於血液循環的調整上起一定的作用，例如在內臟或腦部充血的場合，我們用興奮的刺激，使末梢皮膚部之血管充血，以調節內臟之血量。或是相反的在內臟（或腦部）貧血時，我們就用抑制的刺激，使末梢皮膚部血管之血量減少，以調整血循。這種作用就叫做誘導作用。誘導作用是改變興奮或抑制刺激之強度時特別是對於血管系統的一種主要作用方式。

4. 常用刺針手技的方法——刺針手技的方法，以前因各派別的不同，方式極多。但其施用手技的原則總不外乎上面所說的「補」「瀉」的目的，是不能離開刺激與反應之總的規律的。因此，在總的刺激反應規律原則下，就可以不必拘泥於各種形式的方法了。下面我們只介紹了八種臨床上常用的手技，但在實用時是不妨根據刺針目的的需要加以擴充與變化的。

（一）單刺法——這是刺針法的一種簡單形式。即將針直刺入皮膚達於一定深度後，隨將針拔出之方法。

這種方法適用於最輕微之刺激場合，予以興奮作用，特別於幼兒之治療時尤為適用。

（二）臥針法——這種方法和上一方法的技術操作相同，但自刺入至拔針中間的時間距離延長為5、10、30分鐘或

一小時，在臥針時間內不動轉針體，直到拔針。

這種方法，由於時間的延長，往往可以增大刺激的力量，而呈現抑制作用。

(三) 雀啄法——本法即當刺針入於一定之深度後，以刺手之拇、食指握住針柄作輕速之上下動作，恰如鳥類啄食之方式。這種方法又有輕重二種刺激，前者之動作微弱而時間短促，後者則作較劇烈之運動，並時間可以稍長。

因此，在輕雀啄法時所呈現之作用為興奮之目的，而在重雀啄法時則呈現抑制之目的。

(四) 間歇法——本法相當於古代之提插法。即在刺針入於一定之深度後，擱置一定之時間，復行提上（但不提出皮外）。再擱置一定時間後，復再行刺入，如此反覆操作的方法，一般用於較強之刺激時。

(五) 屋漏法——即在將針刺入皮膚時，分三次入針，而漸次達於最深部，三次刺入之時間要比較迅速，本法可以收獲興奮的效果。

(六) 旋撚法——即在刺入一定之深度後，即將針行左右捻轉之方法。本法可依其刺激力量之強弱而決定其所呈現之效果。

(七) 震顫法——本法主要在使針體之震動以影響神經系作用的方法。其方法可以在刺入後用指輕彈針柄使其震顫，或作輕微之上下左右擺動，或輕輕搖爬纏絡於針柄上之細絲等。在興奮之目的上，本法常表現出良好之作用。

(八) 亂針法——本法為用於高度之抑制作用時，可在刺針穿皮後作種種方向與速度之反覆提插刺法。

5. 古代常用的補瀉手法及其批判——古代常用之補瀉

手法很多，但歸納來看，其形式大同小異，其內容則雖同一方法各書所記亦多出入，至於常用手法則有下述四種：

(一) 提插補瀉法（即三才法）——按照古代三才法之說法認為：本法又可分為二種手技，一即「昇陽法」，一即「降陰法」。但無論何者，均在刺針時，將每一個穴道入為的根據深淺分為三部分，即在上方者為「天部」，中央段為「人部」，最下方則「地部」。天、人、地，合而為三才。

昇陽法為將針直接刺入「地部」（即皮下最深層），然後分三次作階梯狀提出於皮膚外面。

降陰法為將針分三次漸次之下降由「天」→「人」→「地部」最後再由地部直接提出的方法。

而在古代補瀉之意義上，又可分為男女、午前、午後等區別，詳細地說，即：

午前：——補法：男子用「昇陽法」，女子用「降陰法」。

瀉法：男子用「降陰法」，女子用「昇陽法」。

午後：——補瀉手法與上午相反。

(二) 捻轉補瀉法——古代的捻轉補瀉法，是根據了十四經的學說來決定補法或瀉法的捻轉方向的。其方法簡述如下：

(1) 將針向右方捻轉時（即在持針之右手刺手大指向前，食指向後的捻轉方向）：

在刺針於手之三陽經，／身體左側穴道為補法。

與足之三陰經時，＼右側者為瀉法。

在刺針於手之三陰經，／身體之左側穴道為瀉法。

與足之三陽經時，＼右側者為補法。

在刺針於任脈與督脈之穴道時——俱為瀉法。

(2) 將針向左方捻轉時（即在持針之右手（刺手）大指向後，食指向前的捻轉方向）：

在刺針於手之三陽經，
與足之三陰經時 { 身體左側穴道為瀉法。
右側者為補法。

在刺針於手之三陰經，
與足之三陽經時 { 身體左側穴道為補法。
右側者為瀉法。

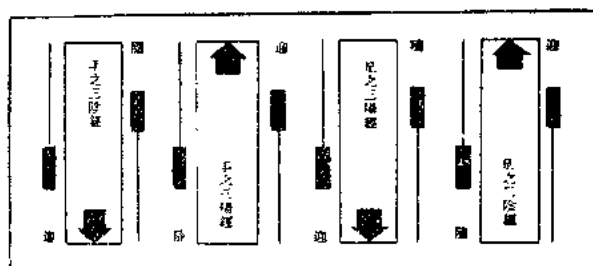
在刺針於任脈與督脈之穴道時——俱為補法。

(三) 呼吸補瀉法——這種方法很簡單主要是：

補法——在深呼氣時入針，深吸氣時出針。

瀉法——與上述相反。

(四) 迎隨補瀉法——本法也是根據了古代經脈學說，認為經脈是一種有一定方向運行的「氣」，在補瀉時，迎其氣而刺之為瀉，隨其氣而刺之為補，略詳細的說，即古人認為：手之三陰經和足之三陽經是從上向下，故刺針時，針尖向下為補，向上為瀉；而手之三陽經和足之三陰經是從上向下，故刺針時針尖向下為瀉，向上為補。



由上圖所列舉的這幾種古代補瀉手法看來，不論是提插捻轉，迎隨與呼吸各法，在近代唯物辯證科學的基礎上，無論在立場方法與觀點上都是沒有任何根據的說法。根據這種說法，機械的依靠想象，定出了人的男女、左右，施術之時期（上、

下午)，施術之方法（呼吸狀態）以至於刺針之方向等之所謂「補瀉」規律，所以它們卻無法找到真正客觀的根據以自圓其說。

實際上這些所謂「補瀉方法」，根據我們初步調查結果，在今天的針灸醫師也很少應用，僅有其名而已。

我們認為新的科學的補瀉方法，也就是「興奮」與「抑制」的兩種方法，而這兩種方法的決定，主要的就是要根據了刺激的強度（輕重）與刺激時間的長短來作基礎的。在今日來說如果不會掌握刺激的力量與可能引起的反應程度，卻去斤較於一些皮相的無據的刺針方式時，就是非常錯誤的一種態度。

唯物辯證科學教導我們：沒有物質基礎存在的現象，是絕不會產生的。因此我們必須要以革命的精神批評的吸收並發展我們祖國的這一個經驗療法，同時我們也必須反對把針灸學指向玄虛化無所根據的唯心論者。使我們祖國寶貴的針灸療法在新的科學領域中發展成為真正確實而更有益於人民的治療法。

6. 刺針時的局部感覺——當針刺入於皮下達一定程度後，在刺針之局部往往可產生出緊張、麻木、局部脹感或放射狀之牽引感，以及痛覺等感覺。按照古代的說法和很多針灸家們都認為這是刺入某穴後，往往可以有一種「氣」的感覺，並且認為這種「氣」可以由局部走到一定的部位。但是這種說法，在很多情況下，是不能都加以有效的規則掌握的。並且，這種感覺可能和病人的心理作用及刺中較大神經枝所引起的局部放射性緊張有密切關係。所以我們在嚴格的科學基礎上，是無法承認這種「氣」的說法的。這種針刺的局部感覺，也可能有一定時間的持續作用，例如在對於疼痛性的病人

予疼痛局部以充分強度的刺激後，這種持久性的強刺激往往可在拔針直後在一段較短時間內繼續保持針後的緊張性感覺。我們認為這種新的較強烈的緊張性感覺，在對於機能亢進時的緩解上，是非常有效的。也正是由於這種新的刺激物所予以軀體的效果之產生，遂緩解並轉移了既存的患處疼痛感覺之在大腦皮質中的興奮竈，使之原來的疼痛症狀得以減輕或消失。

此外，在刺針操作的當時，也可能患者沒有任何感覺，但是對於患者沒有自覺感來說，並不等於沒有刺激的作用。因為人體對於外來刺激物的一定強度刺激都是具有着相當的感受程度與反應能力的。當然一般說來這種患者沒有充分感覺時，刺激效果比較還是小的。根據針灸醫師們的普遍經驗，一致認為針下的緊、脹等感覺的產生在刺激效果的增強上，是具有很重要的意義的。因為醫師可以藉此達到了解病人對於刺激的感受程度，並更好地掌握刺激的效果。

此外，如果把刺針所引起的局部感覺和語言刺激物結合起來應用時，是會更好地發揮第二信號系統對於針灸治療上的作用的。

在語言的應用上，應當主動地暗示病人在刺針後引起一定的感覺擴散現象、指出這種現象產生的必然性，以加強患者注意力的集中。並配合了針下的緊張、痠楚等感覺，引起患者類似感覺之產生。這樣就可以擴大與強化第二信號系統的刺激力量，使患者對於治療過程引起信心與興趣。

反之，如果語言的應用，陷於被動而具有疑似口吻時，就很難達到此項配合治療的目的。因此，語言的應用，必須慎重、適當與合理地加以應用。這樣，我們不僅可以獲得更好的

治療效果，同時對於古人所謂「氣行」的問題，也就不會有什麼奇怪了。

7. 人體對於針灸刺激反應之特點——人體對於針灸刺激所引起的反應特點，乃是和其他的理化學治療方法相同，遵循着共同的生物學規律的。一般來說，在針灸刺激的反應過程中，可以歸納為下列三個特點。

第一，在針灸刺激後，所引起的「反應時間」來看，由於神經系統對於組織作用的反應過程，可能是緩慢而長期的（這就是「營養反射性」的），也可能是在刺激直後立刻表現的，特別由於前者的場合，故在針灸刺激中對於某些慢性疾病的治療，提供了必要的理論根據。這即是說，針灸刺激的效果，並不完全是速效的，也可能是有較長的治程。

第二，在針灸刺激，所引起的「反應範圍」方面看，由於前面說過的營養神經存在的事實，所以對於針灸療法適應症的範圍，應當承認，乃是非常廣泛的。

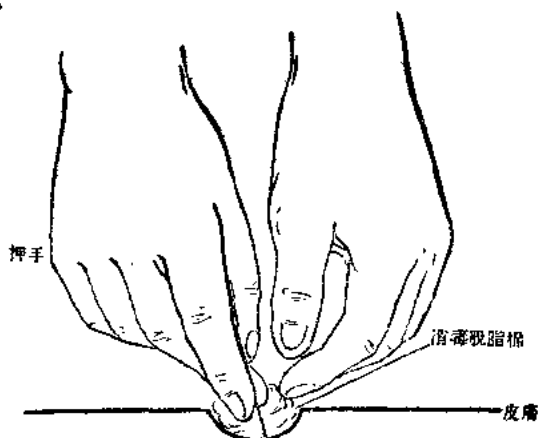
第三，在針灸治療之「反應程度」方面，由於刺激神經的結果，可以引起痕跡性後作用的事實，也可以說明了，為什麼在進行針灸刺激後的某些場合中，必須要經過一定時間後，才能表現出效果，或必須經過多次針灸刺激所引起的累積性效果。

第三節 拔針法及刺針後處理

一、拔針法——在一般拔針時應當用押手幫助進行，最好的方法就是先以已消毒脫脂棉，用押手分開挾持在刺針之皮膚部把持在針體的周圍，並向下方壓按皮膚，再以刺手將針

向上方拔出。拔針後之皮膚面應以消毒之脫脂棉加以輕度揉按。

二、拔針困難的原因與處置——拔針困難的原因主要由於患者在刺針後之肌肉痙攣及收縮，或在留針時間過長，由於針體本身之氧化。所起的出針滯澀等間或有因針體在皮下之曲折所致。



對於拔針困難之處置，不要勉強用力拔出，可先行輕輕揉按刺針周圍的皮膚，並在刺針局部的周圍再予以一針至數針的淺刺激。這樣就可以容易地使原來痙攣之肌肉緩解而出針。對於皮下曲針之處置，應在拔針時隨時注意針軸之方向，使針軸與皮膚垂直之方向謹慎地出針。

三、拔針後的一般處置——拔針後的皮膚面應以消毒之脫脂棉加以輕度之揉按。在若干情況下，拔針後很可能遇到針眼局部出血的現象。這是由於在刺針時刺破內部的小血管所致，遇到這種情況，千萬不要驚慌，因為這是一種常有的現

象。處理方法是以消毒脫脂棉輕揉針眼，一、二分鐘即可止血。

此外由於多次刺針並在一定局部的充血結果，即可慢慢形成赤色或紫色之小點，這就是「針痕」。爲了避免針痕的形成（特別是在患者顏面部），可以略行改變原在的刺激位置而在其附近略有上下移動，因爲刺激點的位置並不是絕對固定不移的，這個原因也正和人體的神經末梢的分佈區域一樣，並不是也不可能是絕對固定不移的。

第三章 在刺針中對於所發生的 異常現象的處置

一、暈針現象——暈針是在刺針時患者所表現的一種神經系統過敏性異常現象。多見於神經質的患者，其原因主要有三：其一是由於刺激的力量過強，並且患者接受刺激時較突然（如在體力勞動之直後等），往往這種外來的刺針刺激，就會變成一種强有力的因子，而超過患者當時生理狀態的接受程度，從而就可以發生暈針；其二是由於患者過於衰弱所致；此外還有一個原因是發生於體溫升高時，這是由於體溫上昇所引起，患者之適應刺激能力也隨之減低，因此也可能發生暈針。

暈針症狀，有輕重不同，在輕度之暈針者，僅有眩暈、煩悶、局部疼痛、惡心、甚則嘔吐等症狀；而重度之暈針者則有心悸亢進、大出汗、血壓下降、瞳孔散大、顏面蒼白、四肢厥冷、甚則呈假死狀態。

重度之暈針，比較易於發生在留針時，當時雖有輕度暈針的現象而患者未向醫師說明，所以引起重度暈針。故在留針時，醫師應隨時注意患者之狀態，以作預防。

處置暈針之方法，在輕度暈針可以改變患者之體位（即在坐位患者可改為臥位等之方法）以調節之，此外也可給予熱湯，重症時可使患者嗅以刺激性氣味如阿莫尼亞液或紅麴丹，

俟其症候稍為緩解即可逐步拔針，並使患者得到充分之休息，此外用針刺入中溝之中央（人中穴又名水溝穴）或手之中指頭尖端（中衝穴），也有幫助針恢復正常之效果。

二、折針——折針的原因主要是由於在刺針前醫師未能充分檢查針體所致。同時亦由於針體過細，患體之劇烈動搖或不適宜之過份猛烈手技等所引起，此外亦有因針柄與針體之結合太鬆而使針滑逸入於皮內者。

處置折針之方法古人雖有磁石法或藥物外塗法等方法，但均不可能使針復出，用手按及鉗鑷之幫助，雖在折針較淺之場合有效，但當折針斷端入於皮下較深時也極困難，因此我們應先行了解一下折針斷端的轉歸問題。

關於折針斷端入於皮下深部後之影響與結果，曾有過很多學者從事於動物實驗的研究（例如日本的大久保適齋及三浦謙之助等人），由這些結果，可以看出一般性結論即：折針斷端除了折針於內臟部周圍可能有着顯著性的障礙外，普通折針斷端雖能够在皮下由於肌肉運動之結果具有一定程度的移行，但此種移行不久即可在不易受到運動的區域（或阻止折針斷端進行的部分）停留下來，並可由於在其周圍的結締組織增生包圍的結果，可逐漸地將其纏繞固定。在某些金屬製針則可以由於氧化結果而分解吸收，並逐漸消失。故一般說來折針問題並不太大，往往不必處置。但刺針是在重要的臟器附近時則必須要慎重處置或請外科醫師施行手術，取出折針，以免發生危險。

此外按照過去民間有一類傳說，是說折針可以沿着人的「經脈」，周流全身，最後到了心臟就可死亡。現在臨床的事實可以證明，這種臆想的說法是沒有科學根據的。

三、穴內曲針——穴內曲針是在刺針中比較易於發生的一種現象，因為在刺針時往往可以由於堅強的皮下組織之助力或患體之動搖使針體發生曲折。對於一般曲針，可不作特殊處置，僅在曲針的拔出時應注意利用押手，並使針體與皮膚面呈垂直之方向，向外拔出，以防患者因疼痛動搖而致折針。

第四章 灸法和其他古代理療法

一、灸法：灸法是利用溫熱刺激作用於一定的身體局部刺激點而發生一定治療效果者。與刺針法同樣，灸法刺激的主要目的也是刺激末梢神經，從而藉了反射作用達到間接反應的效果。

用在燃燒的目的上，古人主要選用了「艾」這種植物。艾是一種最普遍的野生植物，屬於菊科。野生者葉的表面的深綠色，裡面為灰白色的柔毛，葉之邊緣為鋸齒狀分裂，初春時生芽，秋天則開黃色小花。

艾的製法是在五、六月間摘取艾葉，於暑日陽光下曝曬之。使充分乾燥後入冬則置於臼中搗爛，除去雜物，以細羅除去粉末，留下如綿狀纖維狀物，然後貯於器內備用。

灸的方法很簡單，過去一般最常用者不外兩種。

其一是隔薑灸——即將生薑切成薄片，置於刺激點之皮膚面上，然後將粗製艾葉用手搓成小球狀或圓錐狀，放置薑片上叫做艾炷。然後燃點艾炷的最上端，艾葉燃燒後不久即可使其下方之皮膚有溫熱感。此種溫熱感逐漸增加，至灼熱之程度為病人開始不耐受時，即可將艾炷取下。此時即作為灸之「一壯」。在每一個刺激點上每次最少要灸3—5壯，多者可20—30餘壯。

按照古代的灸法，除了隔薑灸以外，尚有以某些藥末塗合成為薄餅進行灸法者，叫做藥灸。

其二是直接灸法——這是不用生薑直接將精製的艾作成麥粒大之小團，放在刺激點施灸的辦法。這種方法必需要用精製艾，先將艾絨搓成長條（如面條狀，粗度亦同），然後截成小段，每段均用手作成上尖下圓之錐體狀（麥粒大）的艾炷，直接放在皮膚上施灸。

我們現在所用的灸法，是根據朱璣同志建議所改良的灸法。這方法就是用裱辛紙（或柔軟菲薄的紙）包裹艾葉如烟捲狀，叫做「艾捲」。一般是應用了手工捲烟器來製造。每個艾捲的粗度和一般烟捲粗度相同或稍粗些，艾葉要捲得充實些。每個艾捲的長度是14—15厘米左右。

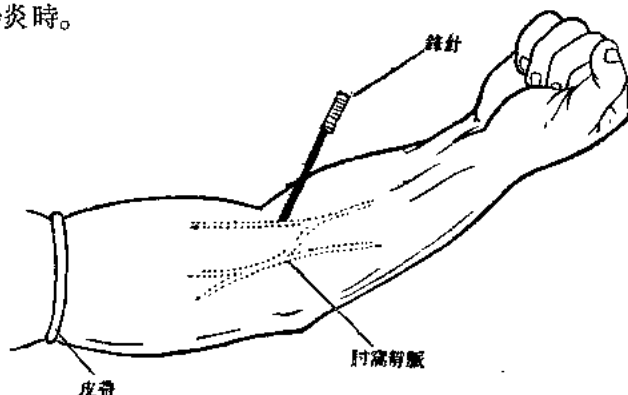
用艾捲灸的方法是把艾捲的先端燃着後，放在已點好標幟的刺激點皮膚面的上方（不要緊貼皮膚）。這樣就可以藉了熱的輻射作用使其下方的皮膚感到溫熱的刺激。皮膚感到溫度刺激的大小是與艾捲與皮膚的距離有關的。因此以手持了艾捲就可以容易地控制熱度的大小，可使病人得到連續不斷的刺激效果。用艾捲的方便處不僅在於省却了臨時換易薑片或艾炷的手續，而且也適合於各種體位的病人，可以用一個艾捲藉了它的長時燃燒，連續地刺激許多刺激點，同時更重要的是，利用艾捲的辦法可以指導某些患者進行協助治療。及家庭自療。這是對於治療的效率上是有很大的意義的。所以這種方法是值得推薦的。

二、放血療法：——放血療法古代又名為「瀉血法」，「刺絡法」等名稱。這是應用鋒針刺激血管放血的一種治療法，而迄今仍廣泛地為針灸醫師們所採用。這種放血療法，可分為靜脈性放血與微細血管性放血二種。這種療法在西洋古代亦有應用，其作用主要是排除瘀血及血中毒素，調整血行，減

低血壓等。

靜脈性放血法主要採取肘窩或膝脛窩部之皮下靜脈，其操作方法主要先行嚴密之局部消毒（先用 2% 碘酒，後用 75% 酒精）然後用圓皮帶將肘部或股部縛緊，這樣就可使皮下的靜脈怒張（如一般靜脈注射），然後用押手按住皮膚，用鋒針迅速而謹慎地刺入皮下穿通血管壁後，再將針拔出，使血液流出。此時再放鬆上部所束縛之皮帶。

靜脈瀉血量每次的 5—20 毫升其適應症主要是用於急性胃腸炎時。



微血管性出血，是用較細的鋒針在手指及足趾末梢尖端，刺破皮膚局部血流之方法。本方法多用於卒倒之救急時使患者呈興奮作用。這也是針灸醫師常用之一種方法，同樣也要予以嚴格的消毒。

三、溫針及火針——溫針和火針都是同時利用針的器械刺激和灸的溫熱刺激的一種方法，但是它們的方法各有不同。

溫針的方法有很多種但主要者有二：

1. 是按照一般刺針法，將針刺入皮膚後，在針柄上端圍

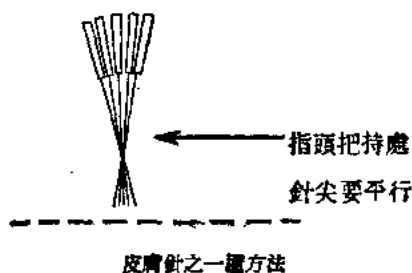
以粗製艾絨，然後燃點之，以發揮其溫熱刺激的作用。

2. 是將生薑片之中央與周圍用粗三稜針穿刺多孔，並消毒後放置於刺激點之皮膚面上，然後將針由中央小孔穿入。並在針體附近繞以艾炷（粗製艾），再予以溫熱刺激之方法。這種溫針的主要作用是可以增強刺激的強度。

火針方法按照古代的說法是將針體在火焰上完全燒紅後迅速的刺入穴道又急速拔出的方法。這種方法，現在用者已經極少，我們還沒有用過。

四、皮膚針——這是對於廣大皮膚面實行刺激的一種方法，它的主要目的是使皮膚下的血管充血，而誘導之減輕內臟炎症疾患的擔負。其方法很多，這裡只介紹一種最簡便易行的方法。將若干等長之細毫針（約 1.5—3.0 厘米長）排作扇面狀使針尖相平（如圖）以醫師右手拇指指持各針體交叉部之中央，然後用針頭撥動針尖於皮膚面上，作前後左右的移動，此種手技應力求輕快迅速並且不宜深刺，以免患者痛苦。

皮膚針多用於小兒科，患者故又名小兒針。



第五章 測定人體刺激點的方法

第一節 取穴法的基礎

一、體表取穴的標幟——於取穴前我應當知道，取穴之目標既不離生體之外，而生活個體龐大複雜，不易鑑別，因此我們在取穴時每多選取若干體表位置上固定之部位，作為取穴時應用之標的物。由此固定位置出發，而測量其他易於變動之經穴位置，以收取穴之實效。並將此作為標的物之位置，稱為取穴之「基準」。

在取穴時，必須由身體上之某一基準作出發點，而後方能測量出經穴之正確位置。

基準之在個體上，依取穴方法可分為二類：一為天然之基準，一為人為之基準。天然基準多藉身體固定不易之位置（動作之關節除外），如骨之突起、結節、切跡、棘、櫛、孔、髌、關節、軟骨、肌腱、肌縫皺紋（一定者）以及爪甲、髮際等，皆可作為一種指標。此外位於體表之各種器官，亦為良好之指示標準，如眉、眼、口、鼻、耳、孔、臍、陰部等，要視其所在的部位而酌為取捨應用之。較不易作為取穴之「基準」者，則如皮下之靜脈，無定之皮膚皺紋，肌肉之隆起，任意局部之凹陷處動脈處，或老年之髮際，以及種種因疾患所呈之體表畸形現象等。因此等位置，均多有變更，且每因人而異。

「人為之基準」為可以變更天然之基準位置，而呈現一

種更適宜於取穴之位置。有如聽會穴之張口取穴，以使下頷小頭移向前方而呈現出凹陷；又如取尺澤時曲肘當其外側所生之約紋頭盡處是穴，伸肘關節時，此紋頭症即消失之類，皆屬於一種非自然狀態下，個體表面所生之指標。此種指標，即「人爲基準」。

此外，尚有與人爲基準之性質相似，而完全藉用人爲方法所假設虛構之若干一定線條，用供取穴之需，而佐助基準之效用，我們即名之爲「基線」。

「基線」依古代之名義，似又可稱之「經脈」。惟「基線」與「經脈」之不同點，即前者爲限局性者，限於一定之位置，界於兩基準間之連接線（假設線）如後章所舉之「頭顱第一線」「頭顱第二線」「頭顱第三線」……等是；而後者則爲全身龐大面積內無基準根據之假設連線。易言之，亦即前者約相當於經脈之局部區分，而後者則爲系統者。

二、取穴法的類別——取穴之方法雖有多種，但以取穴方式論可分爲二類。

1. 尺寸取穴法——在若干取穴方法中，最爲吾人所應用之一種方法，即尺寸取穴法。所謂尺寸取穴法，乃先定出體表上之某一基準並基線後，即將該基準作爲「起始點」，由此出發，沿所定之基線部位，依一定之尺度，而測定出其「終止點」，並由此以測出所求之經穴位置。

2. 特殊取穴法——爲不應用尺度而取穴之方法，又可包括二法，一即利用天然或人爲之體表部位形勢之取穴法；一即利用簡單器械之取穴法。二者以前日均有其廣泛應用範圍，而爲補助尺寸取穴法之不足。

第二節 取穴的方法

一、古代取穴法的測量單位標準——古代測量刺激點的取穴標準主要有下述幾種：

1. 同身寸——同身寸者為取自患者自身之尺度測量單位，其種類有四種：

(一) 中指同身寸——為應用最多，歷史甚久之一種方法（出唐千金方中）。

(1) 中指中節法——甲說（出胎前產後）：取被術者之手，中指屈曲各節互呈直角狀時，取其拇指側（昔稱內側）第1、2節間約紋頭與第2、3節間約紋頭之連結線長度作為1.0寸。

乙說（出綱目、圖翼等）：同甲說。惟取穴時令中指各節互呈鈍角狀取之。

(2) 中指一節法（嵯知梯氏法）——被術者伸直手中指，在中指屈側取掌指關節內之皺紋中央並一、二節關節間之皺紋中央連結線之長度定為1.0寸。

(二) 拇指同身寸：

(1) 拇指內側法——甲說：伸直被術者拇指，取其內側：第一、二關節間，所生之約紋內側端至外側端之連線距離長度作為1.0寸。

乙說：取第1、2關節間內側所生之約紋中央與掌指關節間約紋中央之連線長度作為1.0寸。

(2) 拇指外側法——（青地正鶴氏法）即取拇指第一節之外側橫幅作為1.0寸。

(三) 橫指同身寸：

甲說：取第1、2指骨關節部之橫幅時，以食指爲單位，作爲「一指橫經部」。以食指+中指爲單位時，作爲「二指橫經部」；以食指+中指+無名指爲單位時，作爲「三指橫經部」；以食指+中指+無名指+小指爲單位時，作爲「四指橫經部」（日本文部省法）。

乙說：取第2、3指骨關節部之橫幅時，以食指爲單位時作爲「一指橫經部」依此類推，本說僅三指橫經部（駒井氏說）。

(四) 目寸——（出內經骨度篇）即被術者目內，外眥之連結線作爲1.0寸。但用本法者極少。

上述四種取穴測量之單位並不足以盡符合人體各部之實際情況，故我們主張用下述的測穴法。

二、根據比例數值的測定標準——有鑑於上述同身寸制取穴之缺點，而在取穴上欲求得一比較合理之方法，故我們可將各基本線均設有規定的假設之距離長度（古名：「骨度法」）。這種長度的單位是「寸」。小於寸者爲「分」，大於寸者爲「尺」，均以十進位。這種「寸法」的特點是，不論被測量人體表部位的實際長度如何，均按照這種規定的「寸法」標準，而按照比例加以折算。例如以前臂的一個基本線長度論，按照這種「寸法」的規定是12.0寸。因此在實際應用上，則不論被測量人前臂之實際長度如何，均根據12.0寸的方法進行折算，（折算之方法下述）。故我們不妨視爲這種「方法」在測量刺激點之應用上爲一種「絕對值」，其主要者可如「附表」所列：

基本線的號數	基本線的名稱和位置	基本線的起迄點	(全長) 絕對值
頭部	第1線 頭部橫線	左右兩側頭維穴(位於額角髮際之外上方一橫指部之距離)	9.0寸
	第2線 頭部第1線(頭部正中線)	前髮際邊正中中央↔外枕粗隆	9.5寸
	第3線 頭部第2線(距頭部第1線1.5寸之平行線)	前髮際邊↔枕骨上頂線	8.0寸
	第4線 頭部第3線(距頭部第1線2.25寸之平行線)	前髮際邊↔枕骨上頂線	7.0寸
胸部	第5線 胸部橫線	右側乳頭正中↔左側乳頭正中	8.0寸
	第6線 前胸第1線(前胸部正中線)	胸骨頸切跡↔胸骨體下緣	不必計算其長度其取穴標準可根據胸骨之長度
	第7線 前胸第2線(位於前第1線與第3線之中間, 各距2.0寸)	鎖骨下緣↔第6肋骨	
	第8線 前胸第3線(位於前胸第2線之外側, 以乳頭為中心之垂直線距第1線4.0寸)	鎖骨下緣↔第6肋骨	不必計算其長度, 可根據肋間作為測量標準
	第9線 前胸第4線(位於前胸第3線之外側, 同上, 測量法, 距第3線2.0寸)	鎖骨下緣↔第6肋骨	
側胸部	第10線 側胸線	由腋窩正中央至第11肋骨尖端	
腹部	第11線 前腹第1線(前腹正中線)	上腹部胸骨體下端↔臍部正中	8.0寸
	第12線 前腹第2線(距前腹第1線0.5寸之平行線)(0.5寸之標準係根據上面第5線之規定折算者)	下腹部臍部正中↔耻骨前聯合正中	5.5寸
	第13線 前腹第3線(距前腹第2線2.0寸之平行線)(2.0寸之標準亦係根據第5線之規定折算者)	上腹部巨關穴之水平線↔臍之水平線 下腹部臍之水平線↔耻骨枝之上緣	均可根據第11線之規定作為測量之標準
	第14線 前腹第4線(距前腹第1線4.0寸之平行線)(為與第8線相垂直者)	上腹部巨關穴之水平線↔臍之水平線 下腹部臍之水平線↔風躍帶部	

背 部	第15線	背部第1線（背部正中線）	第7頸椎棘狀突起尾骨比 骨端	不必計算其 長度。可根據 各骨之棘狀突起 及肋間作爲取 穴之標準
	第16線	背部第2線（距背部第1線 1.5寸之平行線）（可根據 第5線之規定作爲折寸 法）	與第15線相平行之線	
	第17線	背部第3線（距背部第1線 3.0寸之平行線）（可根據 第5線之規定作爲折寸 法）	與第15線相平行之線	
上 肢 屈 側	第18線	上肢屈側外線（拇指側線）	肘部：（縫腋前面橫紋頭 ←→窩肘橫紋）	肘部：9.0 寸
	第19線	上肢屈側中線（正中線）	前臂部：（肘窩橫紋←→ 腕關節橫紋）	前臂部： 12.0寸
	第20線	上肢屈側內線（小指側線）		
上 肢 伸 側	第21線	上肢伸側外線（拇指側線）	肘部：（腋縫後橫紋頭← →肘尖）	肘部 9.0 寸
	第22線	上肢伸側中線（正中線）	前臂部：（肘尖←→腕關 節橫紋）	前臂部： 12.0寸
	第23線	上肢伸側內線（小指側線）		
下 肢 伸 側	第24線	下肢內側中線	股部：（鼠蹊韌帶內側頭 ←→股骨內上緣）	股部：12.0 寸
	第25線	下肢外側前線	小腿部：（腓骨小頭←→ 外踝）	小腿部： 14.0寸
	第26線	下肢外側中線		
下 肢 屈 側	第27線	下肢內側後線	股部：（臀部坐骨下溝中 央←→膝關節橫紋正 中）	股部：12.0 寸
	第28線	下肢後側正中線	小腿部：（腓骨小頭←→ 外踝）	小腿部： 14.0寸

三、〔折寸法〕的應用法——上述各基本線之絕對值的規定，完全都是依照歷來針灸之文獻上所沿用之規定，或經過測定者。

應用這種絕對值之規定，以測量刺激點位量標準之方法叫做〔折寸法〕。根據這種方法在實用上可以得到刺激點之正確位置。茲舉例如下：

仍以上述前臂部距設長度由肘關節屈側橫紋正中點，（設

爲甲點)至腕關節掌側橫紋正中點(設爲乙點)間之距離,其絕對值根據規定爲12.0寸。

今欲求出距離乙點之6.0寸,3.0寸,1.0寸及2.0寸各點,用折寸法之步驟即:

1. 取一不易伸縮堅固之線繩,在被測定人前臂之甲、乙、兩點間引直,而於各點上作成一結,在此二點間設其值爲12.0寸。
2. 將二點對折之,取其 $\frac{1}{2}$ 之中點,其一端置乙點上,其直對甲點之另一端即爲所欲求之6.0寸。
3. 如上法再對折之,取其 $\frac{1}{2}$ 之中點,則得3.0寸。
4. 將3.0寸全長之繩作三等分,而取其 $\frac{1}{3}$ 即爲1.0寸。
5. 取上述三等分之 $\frac{2}{3}$,取爲2.0寸。

第三節 選擇刺激點位置的原則

一、古代經絡經穴觀念的批判——在古人對於刺激點(穴道)之認識上,曾命名這種刺激點叫做「經穴」,但這只是一種比較廣義說法,在它的範圍內又包括了古人習慣上所稱呼的下列幾種刺激點。

經穴	1 經穴(狹義者)	$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{正經穴 (十二正經系統者)} \\ (2) \text{奇經穴 (八奇經系統者)} \\ (3) \text{絡脈穴 (絡穴)} \end{array} \right.$	——古文献所記載者(正統的)
	2 經外奇穴	$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{奇穴} \\ (2) \text{別穴} \end{array} \right.$	

- 廣義者 { 3 改正孔穴 (新孔穴) —— 1913 年日本文部省審定者
 4 阿是穴 (或名天應穴) —— 施施於患處之點無一定位置者
 5 要穴 —— 後世學者之經驗推薦者
 6 絡穴 —— 即靜脈血管之穴 (用於瀉血目的)
 7 新經穴 —— 近世學者之發現者。

古代針灸治療目的之單位點，既名為「經穴」而依古人之經驗歸納，集合若干經穴群，使由「點」之面積，而延成「線」之聯繫。因名之為「經脈」。故古人認為經脈者，乃為位於身體表面，具有一定軌道之若干線條，此等經脈系統大概分為二大類，每類又分為若干，即：

名 稱	分 佈 路 線
(一) 正經脈	1. 手太陰 (肺) 經脈 2. 手少陰 (心) 經脈 3. 手厥陰 (心包) 經脈
	—— 皆自胸部起始，經過上肢內側，迄手指端止。
	4. 手太陽 (小腸) 經脈 5. 手陽明 (大腸) 經脈 6. 手少陽 (三焦) 經脈
	—— 皆起自手指，經過上肢外側，肩部、頸部，迄於頭部。
	7. 足太陰 (脾) 經脈 8. 足少陰 (腎) 經脈 9. 足厥陰 (肝) 經脈
	—— 皆起自足部經過下肢內側，腹部迄於胸部。
	10. 足太陽 (膀胱) 經脈 11. 足陽明 (胃) 經脈 12. 足少陽 (膽) 經脈
	—— 皆起自頭部，經過軀幹部，下肢外後側，迄於足部。
(二) 奇經脈	(1) 任脈、(2) 督脈、(3) 陰蹻脈、(4) 陽蹻脈、(5) 陰維脈、(6) 陽維脈、(7) 衝脈、(8) 帶脈。

在此二大類系統中，除奇經中任、督二脈皆有若干獨立之經穴群外，其餘各脈各經穴皆為附屬於正經脈系統內，而無獨立之經穴。故便利上昔人每以「十四經」之名。

此等於各經脈上經穴群之排列方式，皆呈線條樣之順序而次第排列之，各經脈上皆無呈集團狀之存在，其數目則每經有十餘穴至四、五十餘穴不等。

各經脈之所以皆冠以昔人所想象之臟腑名稱者，雖無任何解剖學上之意義，然在昔日學者之治療應用上，每多受其直接之影響，即在各經脈中所隸屬之各穴，每多呈與該經脈同義之該臟腑疾病所現之反應或治療上有關。例如手少陰心脈所隸屬之九穴中，即約有四、五穴即與昔日所認為之「心病」（相當於現代之循環系及神經系病）有治療上的關係，雖然該經脈中之其他經穴並不盡與該經脈有關之臟腑有關，但至少已可表明昔人立論之基礎並非完全建築於玄渺，而仍有其某些經驗上根據，惟此等經驗根據，極為殘缺不全，難稱全面之「點」與「線」之正確與系統關係。故比較客觀之看法，吾人實不如視為先有經驗「經穴」之確定，而後將此多數性質相類之經穴，做成「線」之延長，而於線之路線過程中，所涉之非性質相類經穴恒被涉及，而籠統之指稱為「某經」，「某臟腑」。

總的來說，大約多數的經穴與臟腑關係，都是表現得不明確，或沒有相互關係的。因此經脈經穴學說雖然在科學理論上是一種毫無根據的假想，但是在實際臨床上我們却也不能不考慮到，它們的經驗上的效果，能够由此而進一步的去研究。在新針灸學的科學的整理上，就應當是今後的一個重要課題了。

二、關於決定針灸刺激點位置的標準問題——針灸刺激點（昔日名叫「經穴」或「穴道」）的位置取法，正如一般的經驗醫學的理論遺產一樣，除去其中應用得最多，流行得最廣泛的位置外，其餘大部分的同一名稱的穴道，僅根據了文獻上的記載來說，就有着種種不同的說法，有時甚至一個同名穴道位置因能多到十餘個不同的說法。推究這些不同說法的來源，可能就是古代對於解剖知識的缺乏或不統一，加之在文獻上的記述簡略（包括傳抄的錯誤），此外有因針灸醫師之間不同的經驗所決定者。

正是由於這種刺激點的位置未能劃一，而合理初步地規定，各刺激點位置又為當前針灸工作者們的一項迫切要求。故我們初步所決定的針灸刺激點其標準如下：

1. 主要是根據了針灸臨床醫師們的經驗與其效果。
2. 根據了絕對大多數文獻之共同記載與否。
3. 在同一條件下，則依其解剖生理之特點，選擇其最適當者為根據。

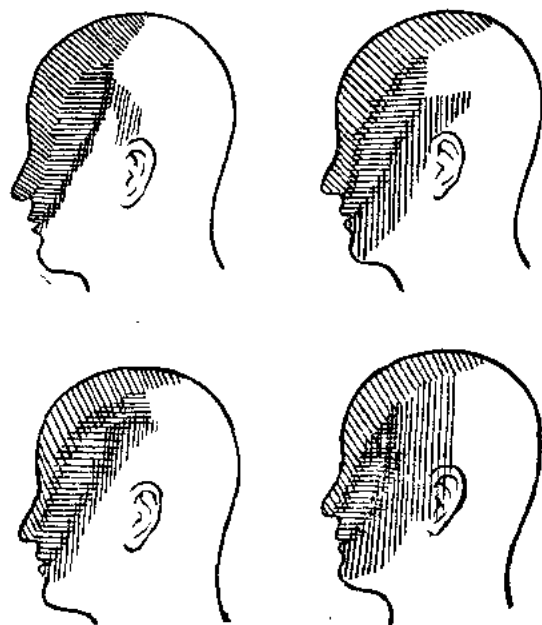
我們必須指出：這種以經驗、文獻及解剖特徵等為根據，對於刺激點的決定來說，僅是現階段針灸療法發展過程中之一種臨時方策，而與針灸療法的進一步發展必然要走向更新的道路，也就是實驗的科學道路。因此我們所介紹的各刺激點位置，均應作為主要的參考形式，而未能也不可能遽下肯定的結論。因為真正最後之肯定結論，乃是與新的生理學、生理病理學、神經學、臨床學等之科學實驗的基礎所不能分割的。而這後一步的工作，正是我們今後所力求達成的目標。因此在今天來說，我們的初步暫定標準，依然不可避免地還是存在着很多缺點的。這就需要今後進一步地用科學實驗與臨床證

明，以期於作到進一步的改正。

三、刺激點的選擇與阿是穴的應用——在刺激點之位置選擇上，首先應注意到其局部附近之各重要臟器與血管的問題，我們應當在這些位置上，避免深刺，並嚴加局部消毒。

我們雖然在各針灸書籍上，將各刺激點規定了一定的位置與距離，但是在事實上，我們還要根據實際情形來決定。同一刺激點的位置，是可以根據當時壓痛的情況和解剖特點略加改變的。有很多初學同志，往往以為刺激點只是一個一定的局部小點，不能有所移動。這是錯誤的。

爲了解釋為什麼每個刺激點(穴道)都不是一個確定刻板位置，而不可移的小點。這是有它較廣泛面積的道理，我們



不妨根據皮神經分佈區域的情況來說明。我們知道，各皮神經的分佈，雖有其一定的範圍，但這範圍並不是絕對的。

再以三叉神經的分佈為例，上圖中就可以看到有四種不同方式的分佈方法：

顏面部知覺神經(三叉神經)分佈區域之種種狀態。

斜線＝第1枝(眼神經) 橫線＝第2枝(上頷神經) 縱線＝第3枝(下頷神經)

由這個圖中我們可以看出皮神經的分佈領域對於每個人來說並不全是非常規則的。因此我們可用同樣理由作為穴道位置可以變動的理論根據。

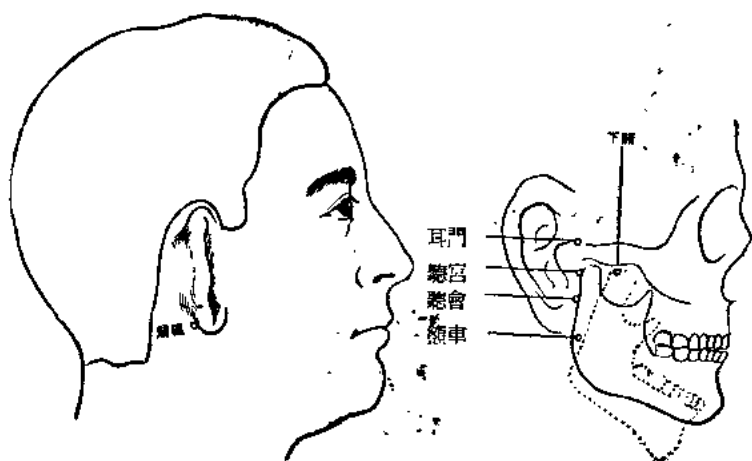
當然，穴道位置之可變動性，也是有着其充分的臨床意義的。因為在疾病時的顯明壓痛點的部位，在大多數的情況下，都應當作為我們刺激部位的中心目標。這是在很多臨床實際中都證明了的一點。因此古代的針灸書籍中就將應用直接刺針於患處方法作為刺針之一主要方法。古人把這種局部刺激的部位即特名為天應穴（或名阿是穴）。

天應穴的意義，根據古代的解釋就是「痛處刺痛，腫處刺腫，痠麻處則刺痠麻」的一種患部刺激。

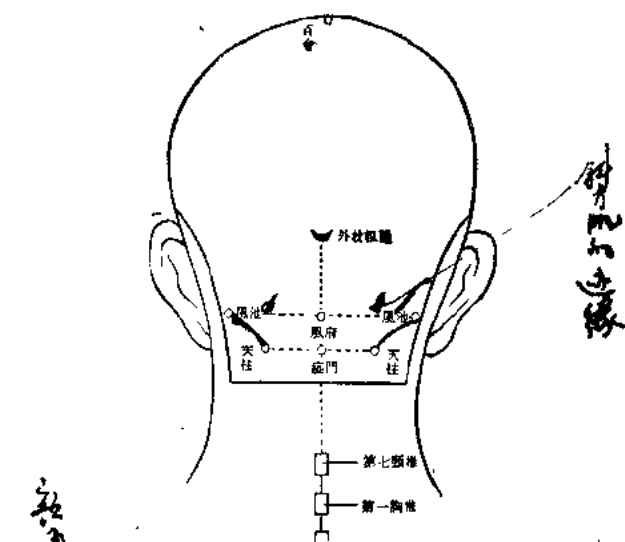
這種直接刺激患處的方法，為刺針之實際應用上開啓了廣大的治療領域。根據我們臨床經驗所知，不少的疼痛性病例或是局部機能障礙的病例，利用這種「阿是」穴的刺激治療，獲得全癒的病例是很多的。而且更主要的一點是在病患附近刺針時可以由於局部的緊張刺激。可以對於原來病患的痛苦部位的神經興奮性相對地降低，因而不僅在病人心理上而且也在對於神經興奮的誘導作用過程中發揮了實際的臨床意義，而呈現「痛點的興奮轉移」現象。因此我願意在這裡特

別指出這種刺激療法的臨床重要性和需要進一步研究的意義。

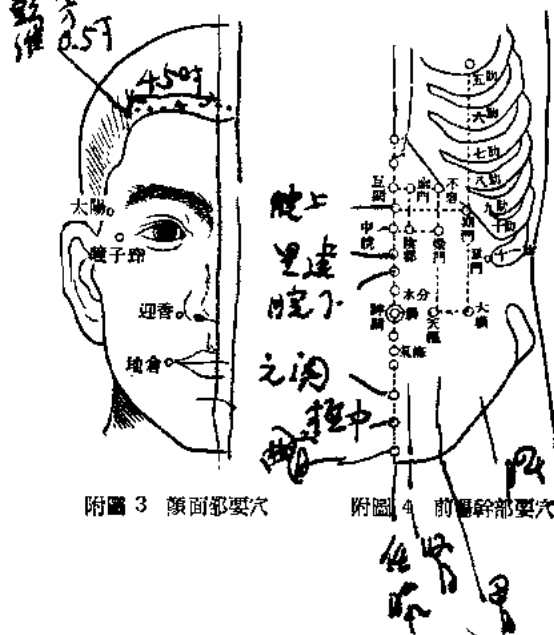
但是，這並不是說完全應當普遍地採用「阿是」穴的方法而忽視了一般刺激點的在經驗上的寶貴意義。我們認為在各刺激點作用的正確科學結論尚未能確立之前，虛心地批判地接收古代的那些寶貴經驗的遺產。使我們不僅有可能要發揚其優點，而且也有可能去分析認識一切缺點。我們相信，這在推動針灸治療普及化與提高基礎上，就是我們每個針灸療法工作者的責任。我們是一定要完成這個祖國人民所交給我們的責任的。



附圖1 側面部要穴

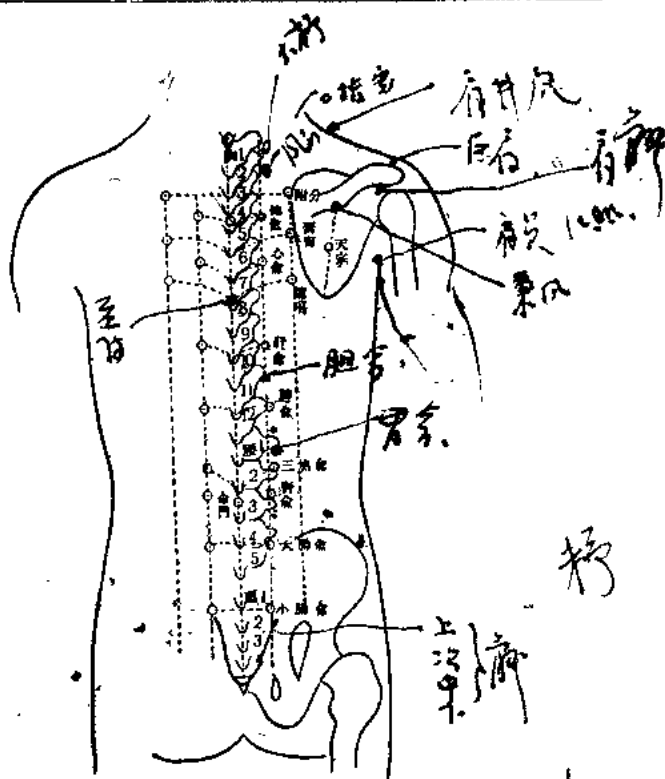


附圖2 後頸部要穴

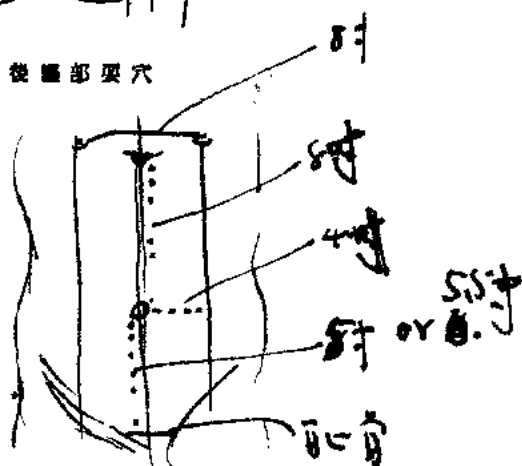


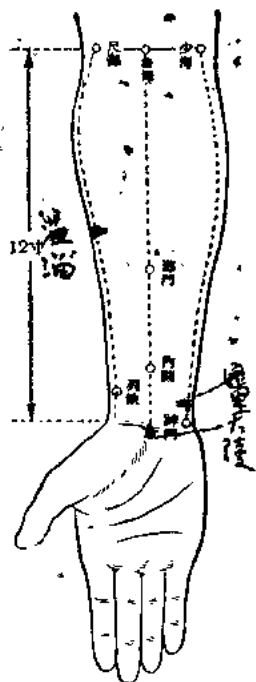
附圖3 顏面部要穴

附圖4 前軀幹部要穴

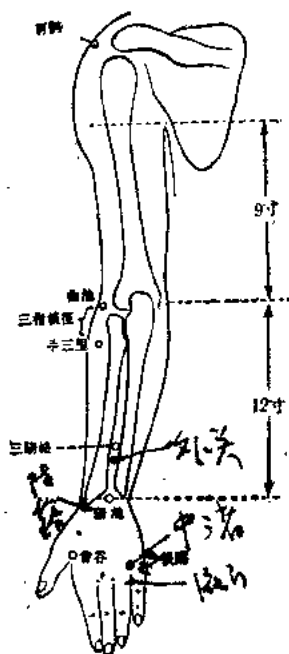


附圖4 後腰部要穴

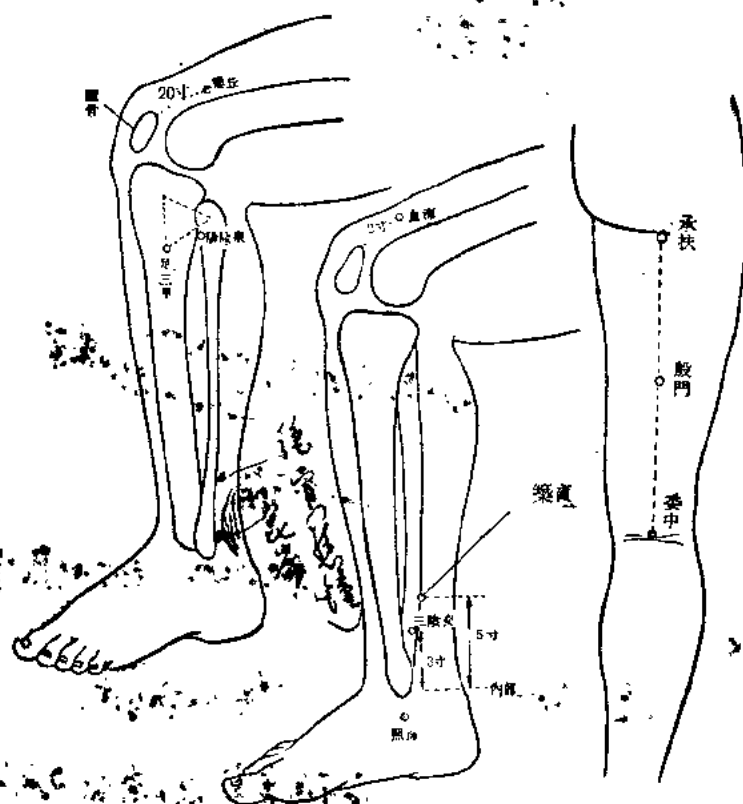




附圖 5 上肢屈側要穴



附圖 6 上肢屈側要穴



附圖 7 下脛外側要穴

附圖 7 下脛內側要穴

附圖 8 下脛後側要穴

新做王如介報
 ①有用穴位的制做，有據確者
 ②「有驗」
 (15星穴)

實用者事少以內

附 錄

針灸參考資料

常用要穴

一、頭頸部

下關穴——位於耳前顴骨弓中央之下方。

應用：牙痛、顏面神經麻痺。

聽宮穴——位於耳前部耳珠之前方，相當於下頷小頭之位置張口時所出現之明顯空隙處。

應用：耳痛、中耳炎。

翳風穴——位於耳後下方，乳突前方凹陷中，重按之牽耳中痛。

應用：中耳炎、耳鳴、偏頭痛、咽炎、牙痛、顏面神經麻痺。

頰車穴——位於下頷骨上，下頷角與下耳根之中央。

應用：下牙痛、顏面神經麻痺、三叉神經痛。

風府穴——在後頭結節與後髮際邊正中點連結線的中點。

應用：傷風、鼻炎、腦充血、神經衰弱、高血壓。

癰門穴——位於風府穴與後髮際邊之中央。

應用：血壓亢進、言語障礙、舌運動不能。

針灸參考資料

表

此穴用毫針(或2毫針)深刺此穴

針灸參考資料 1.5—2.0cm.

此處係
筆
寫
成
上
有
連
去
後
未
針
即
為
中
極

風池穴——位於風府穴之直外方，斜方肌之外緣。

應用：頭痛，感冒，腦充血，鼻炎。

天柱穴——在瘡門穴之旁1.5寸。2 cm.

應用：頭重，頭痛，血壓亢進，腦溢血，半身不遂，神經衰弱。

百會穴——位於顛頂正中線，在前髮際邊正中央與後頭

結節之中央點略向下方。0.3 cm.

應用：腦充血，神經衰弱。

童子髻穴——位於目外眥角之外方0.5寸。

應用：眼病。以記頭痛及上牙痛

太陽穴——位於目外眥角之外上方與髮際邊之中央凹陷處。

0.5 cm.

應用：頭痛，偏頭痛。

二、軀幹部

巨闕穴——位於臍上6.0寸。

應用：心臟病，胃酸過多，胃痙攣，咳嗽及喘。

中脘穴——位於胸骨體下端中央與臍之連絡線的正中

點，相當於臍上4.0寸。0.6, 7. cm. 奇經2.29 (2.1 cm)

應用：各種胃病，消化不良，糖尿病，妊娠惡阻。

水分穴——位於臍上1.0寸。

應用：胃內停水，小便不利，水瀉，腹水，腹膜炎，遺尿。

關元穴——位於臍與恥骨前聯合上緣中央連結線的中點

稍上方。

應用：子宮病，小腸病，泌尿及生殖器官病。

氣海穴——位於臍與關之穴連結線的中央點。

應用：慢性腸病，腹膜炎，膀胱病，小便不禁，夢遺，子宮

用

用

枕粗隆

0.3-4 cm

神經性心悸亢進

此處係
筆
寫
成
上
有
連
去
後
未
針
即
為
中
極

病、腰痛。

天樞穴——位於臍之直外方2.0寸，相當於腹直肌之外緣。

應用：胃腸病（特別是在下痢與便秘時）、腹水。

期門穴——位於乳頭之直下方，第九肋軟骨之下緣。

應用：肝臟病、（肝臟腫大、肝硬化、膽石病）肋膜炎、肋間神經痛。

章門穴——位於第十一肋軟骨之尖端。

應用：肝、脾腫大、腹水、腹膜炎、季肋痛。

大椎穴——位於第一胸椎棘狀突起之直上方。

應用：項背強直、頭痛、腦溢血、解熱、（瘧及其他外感性病）高血壓、精神病。

身柱穴——位於第三胸椎棘狀突起之直下方。

應用：神經疾患、小兒病、呼吸系病（傷風、咳嗽時常用之）。

命門穴——位於第二腰椎棘突之直下方。

應用：救急時（激烈之頭痛、腹痛、激烈之嘔吐等）、腎炎、遺尿症、腰痛、下肢麻痺、淋及帶下。

太杼穴——位於第一胸椎棘突直下方，向外直開1.5寸。

應用：呼吸系病之發熱、項背強痛、咽痛、咳嗽、血壓亢進。

肺俞穴——位於第三胸椎棘突直下方，向外直開1.5寸。

應用：呼吸系病、咳嗽、咯血、喘息。

心俞穴——位於第五胸椎棘突直下方，向外直開1.5寸。

應用：心臟病、血壓高、肋間神經痛、神經衰弱。

肝俞穴——位於第九胸椎棘突直下方，向外直開1.5寸。

肝經之穴

斜

1cm

第2-3小指

第3胸椎的直下方呼吸系病肺病皮膚病

呼吸系病肺病

應用：肺病、喘息、枝氣管炎、咽峽炎。

列缺穴——位於前臂屈側外緣，距腕上橫紋1.5寸。

應用：扁桃腺炎、咽部炎、頭面部之疾患。

郄門穴——位於前臂屈側正中線腕橫紋上5.0寸。

應用：肋膜炎（有顯著效果）、心悸亢進、心臟病、咯血、神經衰弱。

內關穴——位於前臂屈側正中線，腕橫紋上2.0寸。

應用：手腕關節風濕，屈曲不能，心悸亢進。

少海穴——位於肘窩屈側，屈肘時之內側（尺骨側）橫紋頭。

應用：頭面疾患（耳鳴、眼充血、蓄膿症等）、心臟病、肘關節病、尺骨神經痛。

神門穴——位於尺骨莖突與豆狀骨之中間，陷中（上肢屈側內線）。

應用：心臟病、精神病、躁鬱癲癇、神經衰弱、尺骨神經病、腕關節炎。

肩髃穴——位於肩頭部外端之中央。

應用：外感性病、皮膚病、（濕疹、蕁麻疹等）肩胛關節風濕。

曲池穴——位於肱骨外上髁與橈骨小頭之中間，曲臂時之凹陷處。

應用：外感性病、血壓亢進、上肢神經痛、皮膚病。

手三里穴——位於上肢伸側外緣，曲池穴之下方約三指橫徑部。

應用：瘰癧（未化膿者，可灸20--30壯）、中風、半身不遂、頸淋巴腺結核。

合谷穴——位於第1、2掌骨間之凹陷中。

應用：頭面部之充血及內臟充血時，牙痛、頭痛、化膿性疾患。

三陽絡穴——位於上肢伸側中線，腕關節橫紋正中之直上方4.0寸。

應用：頭痛、身體各部分之激烈性痛（特以坐骨神經痛）、臂不能舉。

陽池穴——位於上肢伸側正中線，腕關節橫紋之正中央（略偏拇指側）凹陷。

應用：消化不良、心臟機能不正、妊娠惡阻、腕關節炎。

後谿穴——位於第5掌指關節後之陷中。

應用：一般感冒及呼吸道之急性傳染。

四、下肢部

梁丘穴——位於膝蓋骨外上角之上方2.0寸，股直骨與骨外側肌之間。

應用：腹痛（胃痙攣時有頓挫之效），下痢之各病、膝關節炎。

足三里穴——位於外膝眼之直下方3.0寸。

應用：各種慢性病及消化器病、神經衰弱、腳氣、腓骨神經痛。

環跳穴——位於大轉子之後上方，屈膝時之凹陷處。

應用：坐骨神經痛、股外側皮神經痛、股關節炎。

陽陵泉穴——位於腓骨小頭之前下方7、8分處。

應用：坐骨神經痛、腓骨神經痛、血壓亢進、肌肉性風濕症。

殷門穴——位於腰部正中線，在承扶穴與委中穴之中

夾點。

應用：坐骨神經痛。

委中穴——位於膝腘窩之正中央點。

應用：坐骨神經痛、膝關節炎、腰痛。

血海穴——位於膝蓋骨內上角之上方2.0寸，相當於股直肌與股內側肌之中間。

應用：子宮病（血崩、帶下、月經不調）、小便淋濁、膝痛、膝部炎症。

三陰交穴——位於內踝上四指橫徑部，相當於脛骨之後緣。

應用：各種婦科病，腎臟及膀胱病，下腹膨脹感，腳氣，腿痛。

築賓穴——位於內踝上5.0寸，腓腸肌與比目魚肌之中間，去脛骨後緣一指橫徑部。

應用：古代應用「下毒」用途，如小兒胎毒、藥物中毒、腓腸肌痙攣、腳氣。

照海穴——位於內踝0.5寸，相當於舟狀骨之下方。

應用：腎臟病、腳氣、足膝痛。

常見疾病的要穴治療

一、消化系病：

1. 口內炎——脾俞、胃俞、肩髃、手三里、曲池。
2. 急慢性咽炎、扁桃腺炎——翳風、大杼、風池、尺澤、列缺。
3. 耳下腺炎——翳風、頰車、身柱、手三里。

4. 食道炎——中脘、巨闕、心俞、身柱、風門。
5. 急慢性胃腸炎——梁丘、陽池、三脘、水分、氣海、胃俞、脾俞、章門、足三里、天樞。
6. 牙痛——合谷、溫溜（在前臂部伸側之外線正中點）下關、頰車、地倉、聽宮、翳風。
7. 胃潰瘍——梁丘、陽陵泉、脾俞、胃俞、中脘、期門。
8. 肝臟疾患——期門、章門、中脘、不容、梁門、肝俞、膽俞。
9. 腹膜炎及腹水——水分、章門、中脘、大橫、中極、三焦俞。
10. 便秘——天樞、章門、神門、大橫、期門。

二、呼吸系病：

1. 氣管及支氣管炎——中府、尺澤、曲澤、手三里、身柱、大椎、肺俞、後谿。
2. 喘息——巨闕、梁門、中脘、下脘、肺俞、中府、尺澤。
3. 感冒及百日咳肺炎——後谿、尺澤、風門、身柱、大椎。
4. 肋膜炎——郄門、肩髃、曲池、期門、不容、章門、肝俞、膽俞。

三、泌尿系病：

1. 腎炎、腎盂炎、膀胱炎——腎俞、水分、育俞（臍旁0.5寸）中極、命門、脾俞、三焦俞、照海。
2. 遺尿症——水分、中極、關元、曲骨、腎俞。

四、循環系病：

1. 神經性心悸亢進——郄門、少海、內關、神門、心俞、大椎、身柱、巨闕。
2. 血壓亢進症——頭維、風府、風池、大椎、肩髃、曲池。

合谷、陽陵泉、足三里。

五、神經系病：

1. 顱痛——百會、大椎、肝俞、太陽、風池、肩髃、髃池、合谷、足三里、陽陵（用重刺激）。

2. 神經衰弱症——天柱、風府、神門、心俞、肝俞、手足三里（用輕刺激）。

3. 腦充血及溢血——水溝、痙門、地倉、頭維、風池、風門、大椎、身柱、陽池、其他對症針灸療法。

4. 各種神經痛、神經麻痺及痙攣——均可用患處附近之刺激點或阿是穴但應注意刺激之強度問題，在神經痛與痙攣之場合——應予以重刺激；但在神經麻痺之場合——應予以興奮性的弱刺激。在劇烈之疼痛時可配合三陽絡穴。

六、肌肉與關節病：（肌肉風濕急慢性關節風濕類風濕性關節炎）一般應用小腸俞、後谿、郄門、血海、陰陵泉、築賓，此外多在患處之局部刺激點及阿是穴（阿是穴在本病上可起重要之作用）。

七、婦產科病：主要應用之刺激點、陽池、中脘、氣海、大橫、關元、三陰交、血海、陰陵、腎俞、大腸俞、小腸俞。

八、小兒科病：除根據上述之內科病症外，尚可應用身柱穴及廣泛之皮膚針。

九、耳鼻喉科：耳病主要可應用 翳風、聽宮、下關、頰車、天柱、風門。鼻病主要可應用 迎香、風府、風池、天柱、上星。眼病主要應用 瞳子髎、聽宮、頭維、曲池、合谷、風門、身柱、肝俞。

十、皮膚病及化膿性疾病：皮膚病主要應用 大腸俞、肩髃、曲池、手三里、合谷、陰陵泉、血海、築賓。化膿性病可用灸法：灸手三里、曲池、合谷、列缺、附分、膏肓、譙嚕。